

Buku Ajar **KEPERAWATAN PERIOPERATIF**

Rully Annisa • Anita Setyowati • Nia Handayani

Editor : Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep



Buku Ajar : Keperawatan Perioperatif

Penulis:

Ns. Rully Annisa, S.Kep., M.Kep.

Anita Setyowati, M.Tr.Kep.

Nia Handayani, S.Tr.Kep., M.K.M.

Editor :

Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep



Buku Ajar: Keperawatan Perioperatif

Penulis:

Ns. Rully Annisa, S.Kep., M.Kep.

Anita Setyowati, M.Tr.Kep.

Nia Handayani, S.Tr.Kep., M.K.M.

Editor : Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-63-3

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI



Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul *Buku Ajar Keperawatan Perioperatif* ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami konsep, prinsip, dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam pelayanan keperawatan perioperatif.

Keperawatan perioperatif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada asuhan keperawatan sebelum, selama, dan setelah tindakan pembedahan. Perawat perioperatif memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan pasien, mempersiapkan kondisi fisik dan psikologis pasien, memberikan edukasi, serta bekerja sama dengan tim kesehatan lain untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai keperawatan perioperatif menjadi bekal penting bagi calon perawat maupun tenaga keperawatan yang terlibat dalam pelayanan bedah.

Buku ajar ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami materi secara bertahap. Bab 1 membahas konsep dasar keperawatan perioperatif dan keselamatan pasien sebagai landasan utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Bab 2 menguraikan pengkajian praoperasi dan persiapan pasien, baik dari aspek fisik, psikologis, administratif, maupun edukatif. Selanjutnya, Bab 3 membahas manajemen kecemasan dan edukasi praoperasi sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesiapan pasien menghadapi tindakan pembedahan.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mencapai kompetensi pembelajaran, khususnya dalam memahami peran perawat pada fase perioperatif. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen dalam proses pembelajaran serta bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang aman, profesional, dan berpusat pada pasien.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya keperawatan perioperatif.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
 BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN PERIOPERATIF DAN KESELAMATAN PASIEN.....	
PASIEN.....	1
A. Pendahuluan.....	4
B. Ringkasan.....	16
Referensi	27
 BAB 2 PENGKAJIAN PRAOPERASI DAN PERSIAPAN PASIEN.....	
A. Definisi	31
B. Tujuan.....	31
C. Indikasi	32
D. Persiapan Preoperasi	32
E. Alat dan Bahan.....	33
F. Persiapan pasien/perawat/lingkungan sehari sebelum operasi :	34
G. Masalah Preoperasi	42
H. Evaluasi Preoperasi.....	43
I. Ringkasan.....	49
Glosarium	50
Referensi	51
 BAB 3 MANAJEMEN KECEMASAN DAN EDUKASI PRAOPERASI	
A. MANAJEMEN KECEMASAN	55
B. EDUKASI PRAOPERASI	63
C. RANGKUMAN	77
Glosarium	78
Referensi	80
 Profil Penulis.....	 83

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN PERIOPERATIF DAN KESELAMATAN PASIEN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan perioperatif, alur pelayanan bedah, patient safety, etika–legal, dan pencegahan infeksi sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian praoperasi, identifikasi risiko, dan persiapan pasien secara sistematis serta terdokumentasi.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan perioperatif (pra–intra–pasca) berbasis data untuk menetapkan prioritas masalah dan rencana asuhan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan intervensi perioperatif untuk keselamatan pembedahan (infeksi, posisi, skin integrity, transfusi, monitoring) sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu melaksanakan asuhan pascabedah (PACU, nyeri, PONV, komplikasi, perawatan luka) secara aman dan terukur.	CPMK-5; CPMK-4
CPL-6	Mampu berkomunikasi efektif dalam tim bedah, menggunakan checklist dan dokumentasi, serta melakukan discharge planning dan perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan perioperatif, keselamatan pasien, etika–legal, dan prinsip pencegahan infeksi dalam pelayanan bedah.
CPMK-2	Melakukan pengkajian praoperasi, identifikasi risiko (komorbid, anestesi, perdarahan, infeksi), serta persiapan pasien dan dokumentasinya secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data praoperasi dan intraoperatif untuk merumuskan diagnosis/prioritas masalah serta tujuan asuhan perioperatif yang terukur.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi perioperatif (edukasi, manajemen kecemasan, pencegahan infeksi, posisi, cairan–perdarahan) sesuai standar dan keamanan.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pasca anestesi dan pascabedah (PACU, nyeri, PONV, pencegahan komplikasi, perawatan luka/drain/stoma) dengan evaluasi terukur.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pembedahan melalui kolaborasi tim, surgical safety checklist, monitoring intraoperatif, serta keselamatan transfusi dan perangkat.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Mengevaluasi luaran perioperatif, menyusun dokumentasi dan handover, serta discharge planning dan refleksi perbaikan mutu berbasis indikator.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keperawatan Perioperatif dan Keselamatan Pasien	1.1 Menjelaskan prinsip patient safety perioperatif dan manajemen risiko pada pelayanan bedah.	1.2 Mengidentifikasi isu etika–legal dan keselamatan kerja pada praktik perioperatif.	CPMK-1	CPMK-6; CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep patient safety–etika–PPI perioperatif dan ketepatan keputusan pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-6	Simulasi surgical safety checklist + transfusi aman	Kepatuhan fase sign in–time out–sign out dan ketepatan verifikasi transfusi/monitoring reaksi (checklist).	15	Checklist simulasi; dokumentasi checklist
CPMK-7	Portofolio handover–discharge plan + laporan kasus	Kelengkapan handover/discharge plan (skor checklist) dan kualitas evaluasi luaran berbasis indikator.	15	Handover; discharge plan; laporan kasus

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep keselamatan perioperatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan keputusan etika–PPI pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan pengkajian praoperasi (checklist)	≤60% item terpenuhi; ada item kritis terlewat	61–75% terpenuhi; kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis
2.2 Ketepatan persiapan pasien & dokumentasi	Banyak komponen hilang/keliru	Komponen inti ada; masih ada kekurangan	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap, ringkas, dapat diaudit

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah terhadap data kasus	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung; inkonsisten	Sebagian besar didukung data relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat & konsisten
3.2 Keterukuran tujuan/luaran & rasional	Tujuan tidak terukur; rasional lemah	Tujuan umum; rasional terbatas	Tujuan terukur; rasional jelas	Tujuan sangat terukur; rasional kuat (≥2 alasan/sumber kredibel)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan praktik aseptik/posisi aman (checklist)	≤60% langkah benar; risiko tinggi	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Kualitas edukasi pra/intra (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan asuhan PACU (stabilitas & kriteria transfer)	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Sangat tepat; cepat, aman, terdokumentasi lengkap
5.2 Ketepatan manajemen nyeri/PONV & perawatan luka/drain	Tidak sesuai; evaluasi respons tidak ada	Cukup sesuai; evaluasi terbatas	Sesuai; evaluasi respons jelas	Sangat sesuai; evaluasi komprehensif & pencegahan komplikasi kuat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan surgical safety checklist (fase lengkap)	Banyak item kritis tidak dilakukan	Item inti dilakukan; masih ada kekurangan	Hampir semua item dilakukan konsisten	Semua item dilakukan konsisten; deviasi terdeteksi cepat
6.2 Ketepatan keselamatan transfusi (verifikasi & monitoring)	Verifikasi keliru; monitoring tidak adekuat	Verifikasi cukup; monitoring kurang konsisten	Verifikasi tepat; monitoring adekuat	Verifikasi sangat tepat; monitoring komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan handover/discharge plan (checklist)	Banyak informasi kritis hilang	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; mudah ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi
7.2 Evaluasi luaran berbasis indikator & rencana tindak lanjut	Tanpa indikator; tindak lanjut tidak jelas	Indikator terbatas; tindak lanjut umum	Indikator memadai; tindak lanjut spesifik	Indikator komprehensif; tindak lanjut spesifik, terukur, realistis

A. Pendahuluan

Prosedur bedah merupakan intervensi medis yang bersifat traumatis, sering kali terkait dengan rasa sakit, pendarahan, morbiditas, dan terkadang kematian (Bedaso & Ayalew, 2019). Fase pre operasi, intra operasi, dan post operasi merupakan pengalaman unik pembedahan, yang memerlukan modifikasi yang disengaja pada tubuh pasien (Yudandi, 2021). Fase praoperasi dimulai saat pasien memasuki ruang premedikasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang operasi. Fase intra-operasi dimulai saat pasien tiba di ruang operasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Fase pasca-operasi merupakan lanjutan dari perawatan praoperasi dan intra-operasi, dimulai dari kedatangan pasien di ruang pemulihan hingga intervensi lanjutan di klinik atau rumah sakit (Kurniawati, 2021).

Keperawatan perioperatif merupakan salah satu cabang keperawatan yang memiliki kompleksitas tinggi karena berkaitan langsung dengan tindakan pembedahan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Perawatan perioperatif mencakup seluruh proses asuhan keperawatan mulai dari fase praoperatif, intraoperatif, hingga pascaoperatif. Dalam setiap fase tersebut, perawat

memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fisiologis, psikologis, serta keselamatan pasien. Perkembangan teknologi bedah dan anestesi yang semakin maju membawa dampak pada meningkatnya kompleksitas tindakan medis, sehingga potensi terjadinya kesalahan medis (*medical error*) juga meningkat. Oleh karena itu, penerapan prinsip keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi komponen utama dalam pelayanan perioperatif.

Bab ini akan membahas tentang Konsep Dasar Keperawatan Perioperatif dan Keselamatan Pasien. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami konsep keperawatan operatif serta keselamatan pasien. Sasaran pembaca buku ini Adalah mahasiswa program studi diploma empat keperawatan anestesiologi. Gambaran pembahasan pada bab ini antara lain: Definisi, Tujuan, Fase keperawatan perioperatif, serta konsep keselamatan pasien perioperatif.

1. Definisi Keperawatan Perioperatif

Keperawatan perioperatif adalah pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani prosedur pembedahan, selama pembedahan, dan setelah pembedahan, dengan tujuan memastikan keselamatan dan pemulihan optimal pasien. Keperawatan perioperatif juga diartikan sebagai suatu proses keperawatan yang terintegrasi, meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi terhadap pasien bedah secara holistik. Menurut literatur internasional, keperawatan perioperatif merupakan spesialisasi keperawatan yang bekerja sama dengan tim bedah dalam memberikan asuhan kepada pasien yang menjalani prosedur invasif.

2. Tujuan Keperawatan Perioperatif

Tujuan keperawatan perioperatif tidak hanya berfokus pada keberhasilan tindakan pembedahan, tetapi juga mencakup optimalisasi kondisi pasien secara holistik, pencegahan komplikasi, serta penjaminan keselamatan pasien di seluruh fase perioperatif (pra, intra, dan pascaoperatif). Tujuan utama keperawatan perioperatif meliputi:

a. Menjamin keselamatan pasien selama proses pembedahan

Tujuan utama keperawatan perioperatif adalah memastikan bahwa pasien terbebas dari cedera atau komplikasi yang dapat dicegah selama proses pembedahan.

Implementasi:

- 1) Verifikasi identitas pasien (*right patient*)
- 2) Verifikasi prosedur dan lokasi operasi (*right procedure & site*)
- 3) Penerapan *Surgical Safety Checklist*
- 4) Pencegahan infeksi nosokomial
- 5) Monitoring ketat tanda vital

Keselamatan pasien menjadi prioritas karena tindakan pembedahan memiliki risiko tinggi terhadap kejadian tidak diharapkan seperti:

- 1) Hipoksia
- 2) Perdarahan
- 3) Reaksi anestesi
- 4) Infeksi luka operasi

b. Mengoptimalkan kondisi fisiologis dan psikologis pasien

Keperawatan perioperatif bertujuan menjaga stabilitas fungsi tubuh pasien sebelum, selama, dan setelah operasi.

Aspek yang dioptimalkan:

- 1) Sistem respirasi (mencegah hipoksemia)
- 2) Sistem kardiovaskular (stabilitas hemodinamik)
- 3) Keseimbangan cairan dan elektrolit
- 4) Termoregulasi (mencegah hipotermia)

Contoh:

- 1) Pemberian oksigen
- 2) Monitoring SpO₂ dan tekanan darah
- 3) Manajemen cairan intraoperatif

Dan pasien yang akan menjalani operasi sering mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan stres.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan coping mechanism pasien
- 2) Memberikan rasa aman
- 3) Meningkatkan kepercayaan terhadap tim medis

Intervensi:

- 1) Edukasi preoperatif
- 2) Komunikasi terapeutik
- 3) Dukungan emosional

c. Mencegah komplikasi perioperatif

Perawat berperan penting dalam pencegahan komplikasi yang dapat terjadi pada setiap fase.

Komplikasi yang dicegah:

- 1) Infeksi luka operasi
- 2) *Deep Vein Thrombosis* (DVT)
- 3) Atelektasis
- 4) Shivering dan hipotermia
- 5) *Post Operative Nausea and Vomiting* (PONV)

Strategi:

- 1) Mobilisasi dini
- 2) Teknik aseptik
- 3) Manajemen nyeri
- 4) Latihan pernapasan

d. Memberikan asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien

Perawat tidak hanya fokus pada kondisi fisik, tetapi juga memperhatikan aspek:

- 1) Psikologis
- 2) Sosial
- 3) Spiritual

Contoh:

- 1) Memberikan dukungan spiritual sesuai keyakinan pasien
- 2) Melibatkan keluarga dalam perawatan
- 3) Edukasi lanjutan di rumah

e. Mempercepat proses pemulihan pasca operasi

Keperawatan perioperatif bertujuan mempercepat proses penyembuhan pasien pasca operasi.

Indikator keberhasilan:

- 1) Stabilitasnya tanda vital
- 2) Nyeri terkontrol
- 3) Tidak terjadi komplikasi
- 4) Pasien dapat kembali beraktivitas

Pendekatan:

- 1) Manajemen nyeri efektif
- 2) Early ambulation
- 3) Nutrisi adekuat

f. Meningkatkan kualitas hidup pasien

- 1) Tujuan jangka panjang keperawatan perioperatif adalah memastikan pasien dapat kembali ke kondisi optimal atau mendekati normal setelah operasi.

2) Indikator:

- a) Fungsi tubuh kembali normal
- b) Pasien mandiri
- c) Tidak ada disabilitas tambahan

Keperawatan perioperatif tidak hanya berfokus pada tindakan teknis, tetapi juga pada pendekatan holistik yang mencakup aspek bio-psiko-sosial dan spiritual pasien.

3. Fase Keperawatan Perioperatif

Keperawatan perioperatif terdiri dari tiga fase utama:

Fase Praoperatif (*Preoperative Phase*)

Fase praoperatif adalah periode yang dimulai sejak keputusan tindakan pembedahan ditetapkan hingga pasien dipindahkan ke meja operasi. Fase ini merupakan tahap kritis karena menentukan kesiapan pasien secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Pada fase ini, perawat memiliki peran utama dalam mengidentifikasi risiko, mengoptimalkan kondisi pasien, serta mencegah komplikasi perioperatif sejak dini.

Tujuan utama fase praoperatif adalah mempersiapkan pasien agar siap menjalani operasi secara aman dan optimal.

Tujuan khusus:

- a. Mengidentifikasi status kesehatan pasien
- b. Mengurangi risiko komplikasi intra dan pascaoperasi
- c. Meningkatkan kesiapan fisik dan psikologis
- d. Memberikan edukasi terkait prosedur
- e. Memastikan informed consent terpenuhi
- f. Menjamin keselamatan pasien sebelum tindakan

Fase praoperatif terbagi menjadi dua tahap utama:

Tahap Praoperatif Awal, dimulai sejak keputusan operasi dibuat.

Kegiatan:

- a. Anamnesis dan pengkajian awal
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang (lab, radiologi)
- d. Konsultasi spesialis (bila diperlukan)

Tahap Praoperatif Akhir, Dilakukan 24 jam sebelum operasi hingga pasien masuk kamar operasi.

Kegiatan:

- a. Verifikasi identitas pasien
- b. Puasa (NPO)
- c. Persiapan area operasi
- d. Premedikasi
- e. Checklist praoperatif

Peran perawat:

- a. *Care provider* (Memberikan asuhan langsung)
- b. *Educator* (Memberikan edukasi)
- c. *Counselor* (Memberikan Konsultasi)

Fase Intraoperatif (Intraoperative Phase)

Fase intraoperatif adalah periode yang dimulai sejak pasien masuk ke ruang operasi (kamar bedah) hingga pasien dipindahkan ke ruang pemulihan (PACU). Fase ini merupakan tahap paling kritis karena melibatkan tindakan invasif yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Pada fase ini, fokus utama adalah mempertahankan stabilitas fisiologis pasien, menjamin keselamatan selama prosedur, serta mendukung kelancaran tindakan pembedahan. Fase ini dimulai saat pasien masuk kamar operasi hingga dipindahkan ke ruang pemulihan. ([Repository Poltekkes Tjk][4]).

Kegiatan utama:

- a. Monitoring tanda vital
- b. Menjaga aseptik dan sterilitas
- c. Kolaborasi dengan tim bedah
- d. Posisi pasien yang aman
- e. Pencegahan cedera operasi

Proses Operasi (Time Out – Incision Phase)

Sebelum insisi dilakukan:

- a. Time out (konfirmasi tim)
- b. Penegasan prosedur

Selama operasi:

- a. Monitoring kondisi pasien
- b. Menjaga sterilitas
- c. Menyediakan instrumen

Terminasi Operasi (Sign Out)

Setelah operasi selesai:

- a. Perhitungan alat dan kasa
- b. Dokumentasi
- c. Persiapan pemindahan pasien

Peran perawat:

- a. Perawat scrub
- b. Perawat sirkuler
- c. *Patient safety advocate*

Fase Pascaoperatif (Postoperative Phase)

Fase pasca operatif adalah periode yang dimulai sejak pasien dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pemulihan (*Post-Anesthesia Care Unit/PACU*) hingga pasien mencapai pemulihan optimal atau kembali ke kondisi fungsional semula. Fase ini merupakan tahap kritis karena pasien masih berada dalam pengaruh anestesi dan berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti gangguan respirasi,

hemodinamik, serta nyeri akut. Dimulai sejak pasien keluar dari ruang operasi hingga pemulihan optimal.

Kegiatan utama:

- a. Monitoring hemodinamik
- b. Manajemen nyeri
- c. Pencegahan komplikasi
- d. Perawatan luka
- e. Edukasi lanjutan

Tujuan utama:

Tujuan utama keperawatan pada fase pascaoperatif adalah memastikan pemulihan pasien secara aman dan optimal.

4. Konsep Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Pembedahan menjadi komponen penting dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia selama lebih dari satu abad. Karena insiden cedera traumatis, kanker, dan penyakit kardiovaskular terus meningkat, dampak intervensi bedah pada sistem kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Pembedahan sering kali menjadi satu-satunya terapi yang dapat meringankan kecacatan dan mengurangi risiko kematian akibat kondisi umum. Setiap tahun, jutaan orang menjalani perawatan bedah, dan intervensi bedah diperkirakan mencakup 13% dari total tahun kehidupan yang disesuaikan dengan kecacatan di dunia (WHO, 2024).

Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien akibat kesalahan dalam pelayanan kesehatan melalui identifikasi risiko, pelaporan insiden, serta penerapan strategi pencegahan yang efektif (World Health Organization [WHO], 2024). Dalam konteks perioperatif, keselamatan pasien merupakan upaya terintegrasi untuk memastikan bahwa pasien yang menjalani prosedur pembedahan terbebas dari kejadian tidak diharapkan (*adverse events*) selama fase praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif (AORN, 2020).

Menurut standar pelayanan kesehatan, keselamatan pasien mencakup:

- a. Identifikasi risiko
- b. Pelaporan insiden
- c. Pembelajaran dari kesalahan
- d. Implementasi solusi pencegahan

Tujuan utama penerapan keselamatan pasien dalam keperawatan perioperatif adalah:

- a. Mencegah cedera atau komplikasi yang dapat dicegah
- b. Menjamin ketepatan prosedur, lokasi, dan pasien
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- d. Menurunkan angka kejadian tidak diharapkan (KTD)
- e. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan

Penerapan keselamatan pasien terbukti mampu menurunkan angka mortalitas dan morbiditas yang berkaitan dengan tindakan pembedahan (WHO, 2024). Dalam konteks perioperatif, keselamatan pasien sangat penting karena tingginya risiko komplikasi selama tindakan pembedahan. Prinsip Keselamatan Pasien di Perioperatif, Prinsip utama meliputi:

- a. Identifikasi Pasien
- b. Verifikasi identitas sebelum Tindakan
- c. Penggunaan gelang identitas
- d. Komunikasi Efektif
- e. SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*)
- f. Koordinasi antar tim

Surgical Safety Checklist (SSC)

Checklist ini dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien selama operasi. Tahapan SSC:

- a. Sign In (sebelum anestesi)
- b. Time Out (sebelum insisi)
- c. Sign Out (sebelum keluar ruang operasi)

Faktor Risiko dan Insiden Keselamatan Pasien Perioperatif

Beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien:

- a. Faktor pasien (usia, komorbiditas)
- b. Faktor prosedur (jenis operasi, durasi)
- c. Faktor tenaga kesehatan (kompetensi, komunikasi)
- d. Faktor lingkungan (sterilitas, fasilitas)
- e. Faktor sistem (manajemen rumah sakit)

Kesalahan dalam persiapan pasien dapat menyebabkan peningkatan lama rawat, komplikasi, dan penurunan kualitas hidup pasien. Peran Perawat dalam Keselamatan Pasien, Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan pasien karena berinteraksi langsung selama 24 jam.

Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien terdiri dari:

- a. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) (Cedera yang terjadi akibat tindakan medis)
- b. *Near Miss* (Kejadian yang berpotensi menimbulkan cedera tetapi berhasil dicegah)
- c. Kejadian Tidak Cedera (Kesalahan yang tidak menimbulkan dampak pada pasien)

Peran utama:

- a. *Care provider*
- b. *Patient advocate*
- c. *Educator*
- d. *Coordinator*
- e. *Collaborator*

Perawat juga berperan dalam:

- a. Deteksi dini komplikasi
- b. Implementasi standar keselamatan
- c. Pelaporan insiden (*incident reporting*)

Standar dan Regulasi Keselamatan Pasien, beberapa regulasi terkait:

- a. Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
- b. Standar AORN (*Association of PeriOperative Registered Nurses*)
- c. WHO *Patient Safety Guidelines*

Standar ini bertujuan untuk menurunkan angka kejadian tidak diharapkan (KTD) dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.

Budaya Keselamatan Pasien (*Patient Safety Culture*)

Budaya keselamatan adalah nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung keselamatan pasien (WHO, 2024). Karakteristik budaya keselamatan:

- a. Keterbukaan komunikasi
- b. *Non-blaming culture*
- c. Pembelajaran berkelanjutan
- d. Kepemimpinan yang mendukung

Strategi Peningkatan Keselamatan Pasien Perioperatif

Beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Implementasi checklist keselamatan
2. Pelatihan tim kesehatan
3. Audit dan evaluasi berkala
4. Penerapan evidence-based practice
5. Penguatan sistem pelaporan insiden

Tren Terkini dalam Keperawatan Perioperatif. Beberapa perkembangan terbaru:

- a. Digitalisasi sistem monitoring pasien
- b. *Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)*
- c. *Patient-centered care*
- d. *Evidence-based practice*
- e. Penggunaan teknologi robotik dalam bedah

Keselamatan pasien dalam konteks perioperatif merupakan elemen fundamental yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Prosedur pembedahan yang melibatkan tindakan invasif, penggunaan anestesi, serta kerja sama tim multidisiplin menyebabkan pasien berada pada tingkat risiko tinggi terhadap kejadian tidak diharapkan (*adverse events*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis, terorganisir, dan berbasis bukti guna menjamin keselamatan pasien pada setiap tahap perioperatif.

Penerapan *Surgical Safety Checklist* menjadi salah satu strategi utama yang terbukti efektif dalam menurunkan angka komplikasi dan mortalitas akibat pembedahan. Checklist ini tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi prosedur, tetapi juga sebagai sarana komunikasi tim yang memastikan kesamaan persepsi antar anggota tim terkait tindakan yang akan dilakukan. Penggunaan checklist secara konsisten mampu mengurangi risiko kesalahan seperti salah pasien, salah prosedur, maupun kesalahan lokasi operasi (World Health Organization [WHO], 2024). Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan faktor krusial dalam mendukung keselamatan pasien. Tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu mengidentifikasi risiko, mengambil keputusan klinis secara tepat, serta melakukan intervensi yang efektif. Pelatihan yang berfokus pada komunikasi tim, manajemen risiko, dan simulasi klinis terbukti dapat meningkatkan kinerja tim perioperatif serta menurunkan angka kesalahan medis (AORN, 2020).

Audit serta evaluasi berkala juga merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan keselamatan pasien. Melalui audit klinis, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga sistem pelayanan menjadi lebih adaptif dan mampu meningkatkan mutu layanan secara konsisten. Penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) menjadi pendekatan yang sangat penting dalam keperawatan perioperatif. Dengan mengintegrasikan hasil penelitian terkini, pengalaman klinis, serta preferensi pasien, tenaga kesehatan dapat memberikan

asuhan yang lebih aman, efektif, dan sesuai kebutuhan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil klinis, tetapi juga memperkuat profesionalisme tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan berkualitas (Smeltzer & Bare, 2002).

Penguatan sistem pelaporan insiden (*incident reporting system*) juga memegang peranan penting dalam membangun budaya keselamatan pasien. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan tenaga kesehatan untuk melaporkan kejadian tanpa rasa takut terhadap sanksi, sehingga mendukung terciptanya budaya tanpa menyalahkan (*non-blaming culture*). Data yang diperoleh dari pelaporan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis akar penyebab masalah dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Keberhasilan implementasi strategi keselamatan pasien juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mendukung. Budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) ditandai dengan komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang kuat, serta komitmen seluruh tenaga kesehatan untuk mengutamakan keselamatan pasien. Dalam lingkungan yang kondusif, setiap individu memiliki rasa tanggung jawab dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya kesalahan (WHO, 2024).

Dalam praktik klinis, perawat memiliki posisi strategis dalam penerapan keselamatan pasien perioperatif. Sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan, perawat bertanggung jawab dalam memantau kondisi pasien, mendeteksi perubahan klinis secara dini, serta memastikan bahwa seluruh tindakan dilakukan sesuai standar. Selain itu, peran sebagai *patient advocate* menuntut perawat untuk melindungi hak pasien, termasuk memastikan pasien memperoleh informasi yang memadai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan. Integrasi berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keselamatan pasien tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi antar tenaga kesehatan, dukungan manajemen rumah sakit, serta keterlibatan pasien dan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang aman.

Soal OSCE (CBL)

Skenario:

Stasiun: Pencegahan Risiko Jatuh saat Pasien Ingin ke Toilet

A. Setting Stasiun

- Lokasi: Ruang rawat inap (bedside)
- Waktu: 8–10 menit
- Peran Peserta: Perawat pelaksana jaga

B. Skenario (untuk Peserta)

Pasien lansia di ruang rawat tampak gelisah dan ingin ke toilet sendiri. Keluarga tidak ada. Perawat melihat lantai baru dipel dan licin. Pasien memakai sandal longgar. Anda diminta melakukan tindakan untuk mencegah risiko jatuh dan tetap menghargai keinginan pasien.

Tugas Peserta:

1. Lakukan asesmen cepat risiko jatuh.
2. Lakukan intervensi pencegahan jatuh sebelum pasien mobilisasi ke toilet.
3. Lakukan komunikasi terapeutik.
4. Koordinasi dan dokumentasi singkat tindakan

Instruksi Khusus Penguji

1. Penguji dapat mendekati peserta bila penglihatan kurang terjangkau saat tindakan, dengan posisi di belakang punggung peserta.
2. Penguji tidak memberi arahan, hanya menilai sesuai rubrik.
3. Bila peserta meminta data tambahan, penguji memberikan informasi standar berikut: pasien sadar baik, tampak ingin BAK segera, berjalan tanpa alat bantu namun langkah pelan.
4. Mobilisasi ke toilet cukup simulasi/verbal; fokus penilaian pada keselamatan, komunikasi, dan keputusan klinis.

Aktivitas Belajar Terstruktur

Aktivitas 1 — “Kenapa saya memilih profesi perawat?” (10–15 menit)

- Mahasiswa menulis 5 kalimat: motivasi, harapan, dan nilai yang ingin dibangun.
- Diskusikan: nilai mana yang paling penting untuk keselamatan pasien.

Aktivitas 2 — “Kartu Peran Perawat” (20–30 menit)

- Dosen memberi 8 kartu situasi (contoh: edukasi obat, pasien takut tindakan, koordinasi pemeriksaan).
- Kelompok mengelompokkan peran perawat yang dominan dan menjelaskan alasannya.

Aktivitas 3 — “Kontrak Profesionalisme Skills Lab” (10 menit)

- Sepakati aturan: ketepatan waktu, kebersihan tangan, penggunaan APD sesuai, menjaga privasi, komunikasi sopan.

B. Ringkasan

Keselamatan pasien perioperatif merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek teknis, sistem, dan budaya organisasi. Penerapan strategi seperti penggunaan checklist, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, audit berkala, praktik berbasis bukti, serta sistem pelaporan insiden terbukti mampu meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan risiko komplikasi. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien..

Latihan Evaluasi Bab

A. Pilihan Ganda

1. Keperawatan perioperatif adalah pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien pada fase...
 - A. Praoperatif saja
 - B. Intraoperatif saja
 - C. Pascaoperatif saja
 - D. Praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif
 - E. Pra dan pascaoperatif saja
2. Tujuan utama keperawatan perioperatif adalah...
 - A. Mempercepat tindakan operasi
 - B. Mengurangi biaya perawatan
 - C. Menjamin keselamatan dan pemulihan optimal pasien
 - D. Meningkatkan jumlah pasien operasi
 - E. Mengurangi lama kerja tenaga kesehatan
3. Fase intraoperatif dimulai ketika...
 - A. Pasien masuk ruang rawat
 - B. Pasien masuk ruang operasi
 - C. Pasien dipulangkan
 - D. Pasien sadar penuh
 - E. Pasien diberikan obat
4. Salah satu prinsip keselamatan pasien adalah identifikasi pasien dengan menggunakan...
 - A. Satu identitas
 - B. Dua identitas
 - C. Tiga identitas
 - D. Nama saja
 - E. Nomor kamar
5. Tujuan utama penggunaan *Surgical Safety Checklist* adalah...
 - A. Mempercepat operasi
 - B. Mengurangi biaya
 - C. Meningkatkan komunikasi dan mencegah kesalahan
 - D. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan
 - E. Menggantikan prosedur medis

6. Metode komunikasi efektif dalam keselamatan pasien yang sering digunakan adalah...
 - A. SOAP
 - B. SBAR
 - C. ADPIE
 - D. ABC
 - E. NANDA
7. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada fase pascaoperatif adalah...
 - A. Hipertensi primer
 - B. Atelektasis
 - C. Diabetes mellitus
 - D. Anemia kronis
 - E. Hipotiroidisme
8. Peran perawat sebagai *patient advocate* berarti...
 - A. Menggantikan keputusan dokter
 - B. Melindungi hak dan kepentingan pasien
 - C. Melakukan tindakan medis
 - D. Mengatur jadwal operasi
 - E. Mengurangi beban kerja tim
9. Tahap "Time Out" dalam *Surgical Safety Checklist* dilakukan pada saat...
 - A. Setelah operasi
 - B. Sebelum pasien masuk ruang operasi
 - C. Sebelum insisi dilakukan
 - D. Setelah pasien pulang
 - E. Saat pasien sadar
10. Budaya keselamatan pasien ditandai dengan...
 - A. Menyalahkan individu
 - B. Menyembunyikan kesalahan
 - C. Komunikasi terbuka dan pembelajaran dari kesalahan
 - D. Tidak melaporkan insiden
 - E. Fokus pada hukuman

Jawaban :

1. Jawaban: D
2. Jawaban: C
3. Jawaban: B
4. Jawaban: B
5. Jawaban: C
6. Jawaban: B
7. Jawaban: B
8. Jawaban: B
9. Jawaban: C
10. Jawaban: C

SOAL OSCE PRAANESTESI

1.	No. Stasiun	1
2.	Judul	Pilih judul dengan menebalkan satu kategori berikut: Praanestesi - Intraanestesi - Pascaanestesi - Gawat Darurat dan Bencana - Pasien Kritis - Manajemen Nyeri
3.	Kasus	Lakukan anamnesis AMPLE (<i>Allergy, Medication, Past illness, Last meal, Event/ Environment</i>) dan LEMON (<i>Look, Evaluated, Mallampati Score, Obstruction or Obesity, Neck Mobility</i>)
4.	Tujuan	Tebalkan beberapa kompetensi yang akan diujikan: (sesuaikan blueprint) Anamnesis Pemeriksaan Fisik/Evaluasi Objektif - Penentuan Masalah Kesehatan Anestesi Implementasi - Pendokumentasian
5.	Perilaku Profesional	Tebalkan beberapa item di bawah sesuai dengan kompetensi yang diujikan: A. Komunikasi (anamnesis, kolaborasi, KIE/Konseling) - Komunikasi dengan jelas (menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dengan intonasi yang jelas) - Gestur yang tepat, termasuk mempertahankan kontak mata - Bersikap santun kepada lawan bicara secara tepat dan sesuai - Komunikasi dua arah B. Prosedur kerja (pemeriksaan, tindakan) - Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan, termasuk meminimalkan cedera dan mempertahankan prinsip PI - Melakukan pekerjaan secara tepat dengan teliti dan rapi

		3. Tetap mempertahankan komunikasi walaupun berhadapan dengan panthom 4. Menjaga privasi C. Dokumentasi 1. Tulisan rapi dan jelas 2. Jika ada koreksi, coretan hanya satu garis, diberi paraf, dan diperbaiki
6.	Soal: Skenario dan tugas bagi peserta ujian	SKENARIO Anda sedang menangani pasien (L, 50th, direncanakan menjalani operasi hernia inguinalis elektif dengan anestesi umum. Pasien berada di ruang pra-operasi untuk dilakukan pengkajian pra-anestesi dengan TD: 150/90 mmHg, Nadi: 86 x/menit, RR: 18 x/menit, SpO₂: 98%. Pasien tampak cemas dan menyampaikan bahwa ia memiliki riwayat hipertensi yang rutin dikontrol dengan obat. Pasien menanyakan keamanan anestesi dan kemungkinan efek samping yang akan dialami. TUGAS 1. Lakukan anamnesis AMPLE pada pasien Bila penguji mengatakan "Tidak Ada", peserta ujian tidak perlu melanjutkan pertanyaan/ pernyataan yang serupa. 2. Lakukan pemeriksaan LEMON pada pasien Tulis hasil pemeriksaan kepada penguji 3. Lakukan komunikasi efektif kepada pasien dan keluarga tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar)

7.	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: 2.1. Ujian lokal a. 2-digit jika peserta berjumlah 01-99 b. 3-digit jika peserta berjumlah 100-999 c. 4-digit terakhir jika menggunakan NIM peserta 2.2. Ujian nasional a. 4-digit jika peserta berjumlah ribuan atau b. 4-digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka. 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian: 3.1. <i>Actual mark</i> (0/1/2/3) 3.2. <i>Global rating</i> (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun (interupsi, bertanya, menghentikan, dst) kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE INSTRUKSI KHUSUS 1. Ketika peserta ujian menanyakan selain data di skenario, penguji akan mengatakan “<u>Tidak Ada Data</u>” 2. Jika penguji tidak jelas dalam melihat tugas yang dilakukan peserta, penguji dapat mendekat kepada peserta tetapi tetap berada pada area belakang mahasiswa (jangan sampai ada kontak mata) -> infokan sebelum ujian ke peserta INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Merapikan alat yang sudah digunakan 2. Menyediakan form.
----	-------------------	--

8.	Kebutuhan dan dialog PS	Ada/Tidak ada* Deskripsi PS: Seorang Laki-laki umur 50th, terbaring di atas tempat tidur di ruang transit IBS, terpasang infus Dialog	
		Peserta Ujian (PU)	Pasien Simulasi (PS)
		Mengucapkan salam	Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja)
		Menanyakan nama dan tanggal lahir	Menyebutkan nama ____, tanggal lahir _____
		Menanyakan riwayat Alergi	Menjawab semua pertanyaan dengan kata " Tidak " Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini.
		Menanyakan Medication tentang riwayat mengonsumsi obat-obatan rutin jangka panjang	Menjawab mengonsumsi Captopril 1 x Sehari Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini
		Menanyakan Past Illness tentang riwayat: - Penyakit sistemik penyerta - Operasi dan anestesi sebelumnya	Menjawab ada penyakit penyerta Hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Apabila ditanya riwayat operasi, peserta menjawab belum pernah menjalani operasi dan anestesi sebelumnya. Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini
		Menanyakan Last Meal tentang riwayat terakhir mengonsumsi makanan dan minuman.	Menjawab terakhir makan nasi dan minum 5 jam yang lalu, saat ini puasa.

		Menanyakan <i>Event</i> tentang riwayat: - Mengonsumsi alkohol - Merokok - Menggunakan obat psikotropika/ narkotika.	Menjawab semua pertanyaan dengan kata <u>"Tidak"</u> Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini
		Saat melakukan pemeriksaan: - Melihat daerah wajah pasien - Memeriksa area mulut - Memeriksa area leher	Pasien diam tidak memberikan reaksi
		Saat meminta membuka mulut	Pasien mengikuti perintah membuka mulut namun tetap diam
		Saat meminta membuka mulut dan memasukkan 3 jari di antara gigi	Pasien mengikuti perintah membuka mulut dan dimasukkan 3 jari diantara giginya namun tetap diam
		Meminta menggerakkan leher	Pasien mengikuti perintah menggerakkan leher namun tetap diam
		Peserta Ujian menjelaskan tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan.	Pasien menyimak dengan hati-hati.
		Catatan: Ketika peserta ujian menanyakan diluar dari skenario dialog, PS diam saja dan penguji akan mengatakan <u>"Tidak Ada Data"</u>	

9.	Kebutuhan manekin, alat dan BHP	Kebutuhan manekin: Ada / Tidak ada *		
		No.	Alat dan Bahan	Jumlah
		1.	Tempat tidur pasien + bantal + selimut Pasien	1 Buah
		2.	Troli dengan alas kain berisi seluruh alat dan bahan	1 Buah
		3.	Sarung Tangan Bersih	6 pasang dan 2 pasang cadangan
		4.	Stetoskop	1 Buah
		5.	Masker	1 Buah
		6.	Gelang identitas berwarna biru bertuliskan: Nama: _____ TTL : _____ NRM : _____	1 Buah
*Catatan: - Bahan habis pakai disesuaikan jumlah peserta dalam satu putaran + cadangan (jumlah peserta dalam 1 putaran/ sesi + 20%)				
10.	Layout Ruangan	(Pastikan peserta tidak bloking menutupi penguji, tapi posisi penguji tidak berhadapan langsung dengan peserta) (merujuk pada buku panduan)		
11	Kebutuhan laboran	Ada / Tidak ada * Tugas laboran: 1. Merapikan alat. 2. Membantu maneuver model bila diperlukan karena model tidak mampu bermaneuver sendiri		
12	Penulis	Tim Penyusun Praanestesi (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)		
13	Referensi	1. Nagelhout, J. J., & Elisha, S. (2023). <i>Nurse Anesthesia</i> (7th ed.). Elsevier. 2. Butterworth, J. F., Mackey, D. C., & Wasnick, J. D. (2022). <i>Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology</i> (7th ed.). McGraw-Hill Education. 3. Miller, R. D., et al. (2020). <i>Miller's Anesthesia</i> (9th ed.). Elsevier. 4. American Society of Anesthesiologists. (2023).		

		<i>Practice Guidelines for Preanesthesia Evaluation.</i> 5. Kementerian Kesehatan RI. (2022). <i>Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif</i>. Jakarta: Kemenkes RI.
--	--	---

Referensi

- Association of periOperative Registered Nurses. (2020). *Guidelines for perioperative practice*. AORN.
- Bedaso, A., & Ayalew, M. (2019). Preoperative anxiety among adult patients undergoing elective surgery: A prospective study. *BMC Anesthesiology*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12871-019-0735-0>
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (8th ed.). Elsevier.
- Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2010). *Textbook of medical-surgical nursing* (12th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia. (2014). *Standar praktik keperawatan kamar bedah*. HIPKABI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien*. Kemenkes RI.
- Kurniawan, H., et al. (2023). Koordinasi perawatan perioperatif dalam meningkatkan keselamatan pasien. *Jurnal STIKES Kendal*.
- Kurniawati, D. (2021). Asuhan keperawatan perioperatif pada pasien bedah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Maryunani, A. (2015). *Asuhan keperawatan perioperatif*. Trans Info Media.
- Muttaqin, A., & Sari, K. (2009). *Asuhan keperawatan perioperatif: Konsep, proses, dan aplikasi*. Salemba Medika.
- Safitri. (2021). *Konsep keperawatan perioperatif*. Repository Poltekkes Tanjungkarang.
- Sari, K., et al. (2025). Penerapan keselamatan pasien perioperatif. *Jurnal Universitas Pahlawan*.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2002). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Sumadi, A., et al. (2019). Keselamatan pasien perioperatif. *Jurnal UIA*.
- World Health Organization. (2024). *Patient safety and safe surgery guidelines*. WHO.
- Yudandi, R. (2021). Konsep dasar keperawatan perioperatif. *Jurnal Keperawatan Klinis*.

BAB 2

PENGAJIAN PRAOPERASI DAN PERSIAPAN PASIEN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan perioperatif, alur pelayanan bedah, patient safety, etika–legal, dan pencegahan infeksi sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian praoperasi, identifikasi risiko, dan persiapan pasien secara sistematis serta terdokumentasi.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan perioperatif (pra–intra–pasca) berbasis data untuk menetapkan prioritas masalah dan rencana asuhan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan intervensi perioperatif untuk keselamatan pembedahan (infeksi, posisi, skin integrity, transfusi, monitoring) sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu melaksanakan asuhan pascabedah (PACU, nyeri, PONV, komplikasi, perawatan luka) secara aman dan terukur.	CPMK-5; CPMK-4
CPL-6	Mampu berkomunikasi efektif dalam tim bedah, menggunakan checklist dan dokumentasi, serta melakukan discharge planning dan perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan perioperatif, keselamatan pasien, etika–legal, dan prinsip pencegahan infeksi dalam pelayanan bedah.
CPMK-2	Melakukan pengkajian praoperasi, identifikasi risiko (komorbid, anestesi, perdarahan, infeksi), serta persiapan pasien dan dokumentasinya secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data praoperasi dan intraoperatif untuk merumuskan diagnosis/prioritas masalah serta tujuan asuhan perioperatif yang terukur.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi perioperatif (edukasi, manajemen kecemasan, pencegahan infeksi, posisi, cairan–perdarahan) sesuai standar dan keamanan.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pasca anestesi dan pascabedah (PACU, nyeri, PONV, pencegahan komplikasi, perawatan luka/drain/stoma) dengan evaluasi terukur.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pembedahan melalui kolaborasi tim, surgical safety checklist, monitoring intraoperatif, serta keselamatan transfusi dan perangkat.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran perioperatif, menyusun dokumentasi dan handover, serta discharge planning dan refleksi perbaikan mutu berbasis indikator.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Pengkajian Praoperasi dan Persiapan Pasien	2.1 Melakukan pengkajian praoperasi terstruktur dan identifikasi faktor risiko perioperatif.	2.2 Menyusun persiapan pasien praoperasi (fisik, administrasi, edukasi) sesuai standar.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-7

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian praoperasi + checklist	Kelengkapan item pengkajian risiko dan ketepatan persiapan praoperasi terdokumentasi (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; lembar praoperasi
CPMK-3	Analisis kasus perioperatif (case-based)	Ketepatan prioritas masalah/tujuan terukur berdasarkan data pra/intraoperatif (skor rubrik).	10	Laporan analisis kasus
CPMK-7	Portofolio handover-discharge plan + laporan kasus	Kelengkapan handover/discharge plan (skor checklist) dan kualitas evaluasi luaran berbasis indikator.	15	Handover; discharge plan; laporan kasus

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep keselamatan perioperatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan keputusan etika-PPI pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan pengkajian praoperasi (checklist)	≤60% item terpenuhi; ada item kritis terlewat	61–75% terpenuhi; kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis
2.2 Ketepatan persiapan pasien & dokumentasi	Banyak komponen hilang/keliru	Komponen inti ada; masih ada kekurangan	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap, ringkas, dapat diaudit

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah terhadap data kasus	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung; inkonsisten	Sebagian besar didukung data relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat & konsisten
3.2 Keterukuran tujuan/luaran & rasional	Tujuan tidak terukur; rasional lemah	Tujuan umum; rasional terbatas	Tujuan terukur; rasional jelas	Tujuan sangat terukur; rasional kuat (≥2 alasan/sumber kredibel)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan praktik aseptik/posisi aman (checklist)	≤60% langkah benar; risiko tinggi	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Kualitas edukasi pra/intra (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan asuhan PACU (stabilitas & kriteria transfer)	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Sangat tepat; cepat, aman, terdokumentasi lengkap
5.2 Ketepatan manajemen nyeri/PONV & perawatan luka/drain	Tidak sesuai; evaluasi respons tidak ada	Cukup sesuai; evaluasi terbatas	Sesuai; evaluasi respons jelas	Sangat sesuai; evaluasi komprehensif & pencegahan komplikasi kuat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan surgical safety checklist (fase lengkap)	Banyak item kritis tidak dilakukan	Item inti dilakukan; masih ada kekurangan	Hampir semua item dilakukan konsisten	Semua item dilakukan konsisten; deviasi terdeteksi cepat
6.2 Ketepatan keselamatan transfusi (verifikasi & monitoring)	Verifikasi keliru; monitoring tidak adekuat	Verifikasi cukup; monitoring kurang konsisten	Verifikasi tepat; monitoring adekuat	Verifikasi sangat tepat; monitoring komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan handover/discharge plan (checklist)	Banyak informasi kritis hilang	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; mudah ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi
7.2 Evaluasi luaran berbasis indikator & rencana tindak lanjut	Tanpa indikator; tindak lanjut tidak jelas	Indikator terbatas; tindak lanjut umum	Indikator memadai; tindak lanjut spesifik	Indikator komprehensif; tindak lanjut spesifik, terukur, realistis

A. Definisi

Pengkajian praoperasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data pasien sebelum tindakan operasi untuk mengidentifikasi kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien guna memastikan kesiapan menjalani prosedur pembedahan (Dwi Satriyanto & Samosir, 2023).

B. Tujuan

Pengkajian ini bertujuan mengevaluasi status fisik, mental, dan sosial pasien secara komprehensif guna menemukan risiko kesehatan yang mungkin mengganggu operasi, sehingga tim kesehatan bisa menyusun rencana penanganan tepat, tingkatkan keamanan, kurangi komplikasi, dukung pemulihan cepat, serta beri pemahaman pada pasien supaya siap menghadapi proses secara fisik dan emosional.

C. Indikasi

Proses ini wajib dilakukan pada seluruh pasien praoperasi, baik yang direncanakan maupun darurat, termasuk bedah besar seperti pada abdomen, tulang, atau jantung, maupun kecil seperti pengambilan jaringan atau operasi mata, terutama bagi mereka dengan penyakit penyerta seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, atau alergi, demi pastikan kesiapan menyeluruh sebelum anestesi dan pembedahan.

D. Persiapan Preoperasi

1. Pemeriksaan Penunjang

Persiapan penunjang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan pembedahan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan penunjang, maka dokter bedah tidak mungkin bisa menentukan tindakan operasi yang harus dilakukan pada pasien. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud adalah berbagai pemeriksaan radiologi, laboratorium maupun pemeriksaan lain seperti ECG, dan lain-lain (Ma et al., 2024).

Dokter anestesi juga memerlukan berbagai macam pemeriksaan laboratorium terutama pemeriksaan masa perdarahan (*bledding time*) dan masa pembekuan (*clotting time*) darah pasien, elektrolit serum, Hemoglobin, protein darah, dan hasil pemeriksaan radiologi berupa foto thoraks dan EKG. Berbagai jenis pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan pada pasien sebelum operasi (tidak semua jenis pemeriksaan dilakukan terhadap pasien, namun tergantung pada jenis penyakit dan operasi yang dijalani oleh pasien).

2. Pemeriksaan Status Anestesi

Pemeriksaan status fisik untuk dilakukan pembiusan ditujukan untuk keselamatan selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi demi kepentingan pembedahan, pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri pasien. Pemeriksaan yang biasa digunakan adalah pemeriksaan dengan menggunakan metode ASA (*American Society of Anesthesiologist*). Pemeriksaan ini dilakukan karena obat dan teknik anestesi pada umumnya akan mengganggu fungsi pernafasan, peredaran darah dan sistem saraf.

3. Informed Consent

Informed Consent sebagai wujud dari upaya rumah sakit menjunjung tinggi aspek etika hukum, maka pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien wajib untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan operasi. Artinya apapun tindakan yang dilakukan pada pasien terkait dengan

pembedahan, keluarga mengetahui manfaat dan tujuan serta segala resiko dan konsekuensinya. Pasien maupun keluarganya sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut akan mendapatkan informasi yang detail terkait dengan segala macam prosedur pemeriksaan, pembedahan serta pembiusan yang akan dijalani. Jika petugas belum menjelaskan secara detail, maka pihak pasien/keluarganya berhak untuk menanyakan kembali sampai betul-betul paham. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena jika tidak maka penyesalan akan dialami oleh pasien/keluarga setelah tindakan operasi yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan gambaran keluarga. Oleh karena itu setiap pasien yang akan menjalani tindakan medis, wajib menuliskan surat pernyataan persetujuan dilakukan tindakan medis (pembedahan dan anestesi).

4. Persiapan Mental/Psikis

Persiapan mental merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses persiapan operasi karena mental pasien yang tidak siap atau labil dapat berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Persiapan mental dapat dilakukan dengan bantuan keluarga dan perawat. Kehadiran dan keterlibatan keluarga sangat mendukung persiapan mental pasien. Keluarga hanya perlu mendampingi pasien sebelum operasi, memberikan doa dan dukungan pasien dengan kata-kata yang menenangkan hati pasien dan meneguhkan keputusan pasien untuk menjalani operasi.

5. Obat-Obatan Premedikasi

Sebelum operasi dilakukan pada esok harinya. Pasien akan diberikan obat-obatan premedikasi untuk memberikan kesempatan pasien mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Obat-obatan premedikasi yang diberikan biasanya adalah valium atau diazepam. Antibiotik profilaksis biasanya diberikan sebelum pasien dioperasi. Antibiotik profilaksis yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi selama tindakan operasi, antibiotika profilaksis biasanya diberikan 1-2 jam sebelum operasi dimulai dan dilanjutkan pasca bedah 2- 3 kali.

E. Alat dan Bahan

1. Formulir pengkajian praoperasi
2. Alat tulis
3. Stetoskop
4. Tensimeter
5. Termometer
6. Pulse oximeter
7. Rekam medis pasien

F. Persiapan pasien/perawat/lingkungan sehari sebelum operasi :

1. Memberikan dukungan emosional, menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan spiritual bila diperlukan
2. Melakukan pembatasan diet pre operasi
3. Menyiapkan kebutuhan eliminasi selama dan setelah pembedahan
4. Mencukur dan menyiapkan daerah operasi

Hari saat pembedahan dan anestesi :

1. Mengecek alat-alat penunjang dan obat – obatan telah lengkap
2. Mengecek tanda – tanda vital
3. Mengecek *informed consent*
4. Penilaian ASA

Klasifikasi status fisik menurut *American Society of Anesthesiologists* (ASA) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai kesehatan pasien sebelum operasi. Pada tahun 1963 saat publikasi dari klasifikasi tersebut, dilakukan 2 modifikasi. Pertama, kelas sebelumnya 5 dan 6 telah dihapus dan kelas yang baru yaitu kelas 5 dinyatakan untuk pasien yang hampir mati tidak diharapkan untuk bertahan hidup 24 jam, dengan atau tanpa operasi. Kedua, kelas terpisah untuk keadaan darurat (*emergency*) ditulis dengan huruf "E". Pada tahun 2014, ASA merevisi sistem tersebut dengan menambah kelas keenam yang digunakan untuk tujuan pendonoran organ. Tujuan dari penilaian status fisik ASA demikian untuk mengoptimalkan pasien dan dalam keadaan terbaik sebelum pasien menjalani operasi dan anestesi. Berbagai risiko yang berkaitan dengan anestesi pada semua pasien dengan penyakit penyerta harus dinilai. Klasifikasi Status Fisik ASA antara lain:

a. ASA I

Pasien normal (sehat), tidak ada masalah medik, tidak ada gangguan organik, fisiologis atau kejiwaan, selain penyakit yang akan dioperasi. Contoh : Sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi atau mengkonsumsi alkohol secara minimal.

b. ASA II

Pasien memiliki penyakit sistemik ringan. Contoh : hipertensi, riwayat asma, atau diabetes mellitus terkontrol. Gangguan sistemik ringan, tanpa batasan aktivitas fungsional, memiliki penyakit yang terkontrol dengan baik dari satu system tubuh, hipertensi terkontrol atau DM tanpa efek sistemik, merokok tanpa penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

c. ASA III

Pasien dengan penyakit sistemik berat, tetapi tidak membuat pasien tidak mampu beraktivitas. Contoh: angina stabil, serangan jantung tua, hipertensi tidak terkontrol, obesitas morbid, gagal ginjal kronis, penyakit bronkospastik dengan gejala intermiten. Terdapat beberapa keterbatasan fungsional, memiliki penyakit lebih dari satu system tubuh atau satu sistem utama yang terkendali, tidak ada bahaya kematian.

d. ASA IV

Pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa. Contoh : pasien dengan gagal jantung derajat 3 dan hanya bisa berbaring di tempat tidur saja, pasien dengan setidaknya satu penyakit berat yang tidak terkontrol atau pada tahap akhir, kemungkinan risiko kematian, angina tidak stabil, PPOK bergejala, gejala CHF, kegagalan hepatorenal.

e. ASA V

Pasien dengan atau tanpa operasi diperkirakan meninggal dalam 24 jam atau tidak diharapkan untuk hidup lebih dari 24 jam tanpa operasi. Contoh : risiko besar akan kematian; kegagalan multiorgan, sindrom sepsis dengan ketidakstabilan hemodinamik, hipotermia, dan koagulopati tidak terkontrol.

f. ASA VI

Pasien mati batang otak yang organnya akan diambil untuk didonorkan.

5. Penilaian LEMON

Penilaian pra-operasi adalah pemeriksaan klinis yang dilakukan sebelum anestesi untuk tindakan pembedah atau non-bedah prosedur yang dilakukan merupakan tanggung jawab dokter anestesi. Pemeriksaan LEMON merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan sebelum operasi/anestesi pada pernapasan pasien. Pemeriksaan fisik pada gigi-geligi, membuka mulut, lidah yang relative besar sangat penting untuk diketahui, apakah akan menyebabkan kesulitan dalam tindakan laringoskopi intubasi. Leher pendek dan kaku kuduk juga dapat menyebabkan kesulitan dalam intubasi (Lyvia et al., 2025). Indikator pemeriksaan fisik tersebut dapat dilakukan dengan pemeriksaan LEMON.

Pemeriksaan dengan Metode LEMON (*Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction or obesity, Neck mobility*).

a. *Look externally* atau lihat kondisi bagian luar (wajah)

Mencari indikator eksternal dari intubasi endotrakeal yang sulit. Bentuk wajah yang tidak normal, cachexia ekstrim, gigi yang buruk, mulut tidak bergigi, obesitas morbid, langit-langit tinggi melengkung, leher pendek, gigi depan besar, bekas luka operasi yang menunjukkan bekas luka trakeostomi sebelumnya, menunjukkan pasien mungkin mengalami trakeomalasia, mulut

sempit, wajah , atau patologi leher merupakan salah satu indicator kesulitan intubasi.

b. *Evaluate thyromental distance*

Mengevaluasi jarak mandibular dan hyoid dengan jari, aturan 3- 3-2. Aturan 3-3-2 berfungsi untuk memperkirakan apakah anatomi leher akan memungkinkan pembukaan tenggorokan dan laring yang sesuai, berfungsi untuk memperkirakan secara kasar kesejajaran bukaan untuk visualisasi langsung laring saat intubasi.

c. *Mallampati*

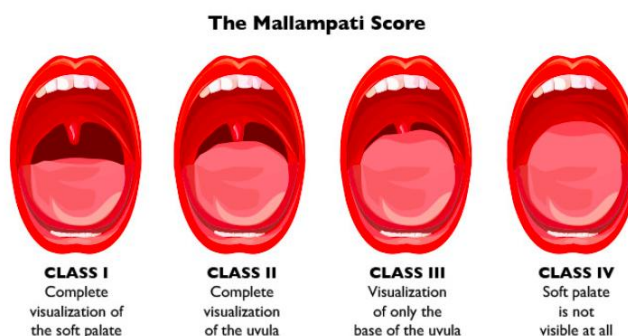
Biasanya dilakukan dengan melihat lidah didalam rongga mulu, semakin besar lidah menghalangi pandangan faring, maka semakin sulit dilakukannya intubasi.

Skoring Mallampati adalah suatu sistem yang didasarkan pada anatomi mulut dan pandangan dari berbagai struktur anatomi apabila seseorang membuka mulut selebar mungkin. Penilaian dilakukan dalam posisi duduk dan tidak dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Skor kelas I diartikan mudah, dan kelas IV adalah yang paling sulit.

Klasifikasi Mallampati

- 1) Kelas I : pilar faring, ovula dan palatum mole terlihat jelas, seluruh tonsil terlihat jelas.
- 2) Kelas II : ovula dan palatum mole terlihat jelas, sedangkan pilar faring tidak terlihat, setengah dari fossa tonsil terlihat.
- 3) Kelas III : hanya palatum mole yang terlihat.
- 4) Kelas IV : pilar faring, palatum mole, ovula tidak terlihat sama sekali.

Kelas I dan II merupakan bentuk yang paling mudah untuk dilakukan intubasi dibandingkan kelas III dan IV, kelas III dan IV merupakan kelas yang paling sulit untuk dilakukan intubasi. Untuk menghindari hasil positif palsu atau negative palsu, tes ini sebaiknya di ulang sebanyak dua kali.



Gambar 2. 1 Skor Mallampati
Sumber : (Putra Fratama et al., 2024)

d. *Obstructiona or obesity*

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah ada benda asing pada jalan nafas pasien. Penilaian jalan nafas yang dapat terhalang oleh benda asing seperti abses, tumor, pembengkakan jaringan lunak seperti pada korban luka bakar atau hematoma yang meluas pada pasien trauma. Perlu dilihat juga pada pasien yang memiliki kelebihan berat badan, apakah ada penebalan dinding pernapasan dan leher yang menyulitkan jalan nafas.

e. *Neck mobility*

Lingkar leher lebih besar dari 68-69cm adalah sugestif dari kesulitan dalam visualisasi pembukaan glottis. Pada pasien yang waspada dan terjaga, lihat apakah pasien dapat meletakkan dagu mereka di dada dan seberapa jauh mereka dapat memiringkan kepala ke belakang. Mobilitas leher yang menurun merupakan prediktor negatif dari komplikasi intubasi.

1) Tujuan pemeriksaan LEMON

Penilaian jalan nafas adalah kunci dari kesukseksesan jalan nafas pada saat intubasi. Secara anatomi dan fungsional, pemeriksaan fisik dapat dilakukan untuk mengetahui kesulitan intubasi endotrakeal. Tujuan dari penilaian pra operasi adalah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan operasi dan anestesi, untuk meningkatkan kualitas perawatan peroperatif, untuk mengembalikan pasien ke tingkat fungsi yang diinginkan dan untuk mendapatkan pasien persetujuan pasien untuk melakukan anestesi. Penilaian ini harus bergantung pada penggunaan rasional informasi dari medis pasien catatan, wawancara klinis, pemeriksaan fisik, dan beberapa tes tambahan (Nicolaus Trijoko, 2024).

2) Cara cara pemeriksaan LEMON

Pemeriksaan dengan metode LEMON (*Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction or obesity, Neck mobility*)

a) *Look externally* atau lihat kondisi bagian luar (wajah)

(1) Lihat apakah ada micrognathia, adanya jaringan sikatrik bekas operasi sebelumnya, trauma dan pendarahan pada wajah.

(2) Lihat apakah bagian wajah terdapat rambut yang dapat mengganggu proses fiksasi tube.

b) *Evaluate thyromental distance*

(1) Buka mulut pasien, gunakan 3 jari pasien dan ukur buka mulut pasien. Jika jaraknya kurang dari 3 jari, menunjukkan posisi laring lebih anterior dan sulit dilakukan intubasi.

(2) Ukur pada daerah mandibular pasien menggunakan 3 jari dimulai dari mentum hingga tulang hyoid.

(3)Ukur jarak antara tulang hyoid hingga tiroid menggunakan 2 jari pasien.

c) *Mallampati* atau lakukan pemeriksaan *mallampati*

(1)Posisikan pasien duduk dengan mulut terbuka dan lidahnya menonjol tanpa phonating

(2)Melihat anatomi rongga mulut yang didasarkan pada visibilitas dasar uvula, pilar faucial. Grading: Tampakkan faring pada saat mulut terbuka maksimal dan lidah dijulurkan maksimal. Mallampati dibagi menjadi 4 grade :

- Grade I : Pilar faring, uvula, dan palatum mole terlihat jelas, seluruh tonsil terlihat jelas
- Grade II : Uvula dan palatum mole terlihat sedangkan pilar faring tidak terlihat, setengah keatas dari fossa tonsil terlihat
- Grade III : Palatum mole dan durum masih dapat terlihat jelas
- Grade IV : Pilar faring, uvula, dan palatum mole tidak terlihat, hanya palatum durum yang terlihat.

d) *Obstruction or obesity*

(1)Periksa apakah ada benda asing di jalan nafas pasien.

(2)Cek apakah pasien obesitas memiliki masalah di ketebalan leher.

e) *Neck mobility* atau gerakan leher pasien.

(1)Lakukan ekstensi leher dan fleksi leher, ujung dagu menyentuh dada

(2)Leher yang pendek

(3)Keterbatasan gerak leher disebabkan operasi sebelumnya atau adanya arthritis. Hasil pemeriksaan LEMON dilaporkan kepada dokter anestesi. Semua pemeriksaan LEMON didokumentasikan dalam rekam medis pasien.

6. Melanjutkan persiapan nutrisi dan hidrasi

Persiapan nutrisi dan hidrasi menjadi bagian penting dalam pengkajian praoperasi untuk memastikan kondisi metabolik pasien tetap stabil sebelum tindakan pembedahan. Perawat menilai status nutrisi, keseimbangan cairan, riwayat makan terakhir, serta memastikan pasien menjalani puasa sesuai ketentuan jenis operasi dan anestesi. Cairan intravena dapat diberikan sesuai instruksi dokter untuk mencegah dehidrasi dan menjaga kebutuhan cairan tubuh.

7. Melepaskan protese dan kosmetik

Pelepasan protese dan kosmetik dilakukan sebagai upaya keselamatan pasien selama prosedur operasi. Semua benda seperti gigi palsu, alat bantu dengar, lensa kontak, wig, perhiasan, jam tangan, kosmetik, dan cat kuku harus dilepas sebelum pasien masuk kamar operasi. Tindakan ini bertujuan mencegah

cedera, kehilangan barang pribadi, gangguan pemantauan sirkulasi, serta memudahkan akses dan observasi selama tindakan anestesi dan pembedahan.

8. Melakukan perawatan mulut

Perawatan mulut bertujuan menjaga kebersihan rongga mulut, meningkatkan kenyamanan pasien, serta menurunkan risiko infeksi sebelum operasi. Tindakan yang dilakukan dapat berupa menyikat gigi, berkumur, membersihkan gigi palsu, dan memastikan tidak ada sisa makanan di dalam mulut. Kebersihan mulut penting terutama pada pasien yang akan menjalani anestesi umum karena dapat mengurangi risiko aspirasi maupun komplikasi lain selama tindakan.

9. Mempersiapkan catatan yang diperlukan selama pre operasi

Persiapan catatan preoperasi merupakan langkah administratif yang penting agar proses pembedahan berjalan lancar dan aman. Dokumen yang harus dipastikan lengkap meliputi rekam medis, hasil laboratorium, hasil radiologi, formulir informed consent, lembar asesmen keperawatan, catatan alergi, serta identitas pasien. Kelengkapan dokumen membantu tim bedah dalam pengambilan keputusan klinis dan mencegah kesalahan prosedur.

10. Memberikan obat –obatan yang perlu diberikan (sesuai order dokter)

Pemberian obat-obatan sesuai order dokter menjadi bagian dari persiapan medis pasien sebelum operasi. Obat yang diberikan dapat berupa antibiotik profilaksis, obat penenang, antihipertensi, antasida, atau terapi lain sesuai kondisi pasien. Perawat harus memastikan prinsip benar pemberian obat, memantau respons pasien, serta mendokumentasikan waktu dan jenis obat yang telah diberikan untuk mendukung keselamatan pasien selama perioperatif.

11. Pengkajian AMPLE

Pengkajian AMPLE ini meliputi A: *Allergies*, M: *Medication*, P: *Past Illnes*, L: *Last meal*, dan E: *Environmet*.

a. Alergi (Allergies)

Alergi merupakan suatu perubahan yang bersifat spesifik dari respon tubuh dan terjadi karena reaksi mekanisme atigen hingga antibodi. Alergi atau yang biasa disebut dengan hipersensitivitas merupakan bentuk respon kekebalan pada rangsangan antigenik yang terjadi pada orang yang awalnya peka. Antigen, alergen, protein, polipeptida, atau molekul yang lebih kecil kemudian terikat dengan protein yang menjadi pembawa. Selain itu, alergen mungkin juga ada pada zat itu sendiri, metabolit, maupun produk pemecahan.

b. Medikasi (Medication)

1) Tipe-Tipe Hipersensitivitas

Dalam Buku Ajar Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Alergi Kulit, hipersensitivitas dikelompokkan dalam 4 macam tipe (Ago, 2016).

a) Reaksi Tipe I (Reaksi Hipersensitivitas Langsung)

Hipersensitivitas ini terjadi karena adanya pengikatan antigen pada antibodi IgE yang sudah ada sebelumnya di permukaan sel mast maupun hasil basofil dalam pelepasan tempat terjadinya inflamasi yang terjadi sebelumnya kemudian akan disintesis. Yang masuk dalam kategori hipersensitivitas seperti syok anafilaksis, asma, alergi, serta reaksi obat akut.

b) Reaksi Tipe II

Reaksi hipersensitivitas tipe ini berkaitan dengan peningkatan antibodi IgM maupun IgG dengan antigen terikat sel. Kejadian kaskade komplemen serta kerusakan sel inang dapat terjadi akibat peningkatan antigen-antibodi. Erythroblastosis fetalis merupakan hemolisis yang terjadi pada janin akibat reaksi antigen-antibodi darah ibu dengan darah janin menjadi salah satu contoh reaksi tipe II. Hipersensitivitas pada tipe II ini berupa hipertiroidisme, miastenia gravis, dan autoimun.

c) Reaksi Tipe III

Reaksi ini terjadi saat kompleks imun ada dan berkaitan dengan antibodi. Kompleks ini dibersihkan oleh sirkulasi sistem fagositik. Pada saat adanya peningkatan jumlah kompleks yang bersirkulasi bersama vasoaktif amina kemudian meningkatkan permeabilitas vaskular akhirnya pengendapan kompleks imun pada jaringan perifer lebih disukai. Hipersensitivitas pada tipe II ini berupa penyakit serum dan sistemik lupus eritematosus.

d) Reaksi Tipe IV

Pada reaksi tipe IV antibodi tidak berperan seperti reaksi hipersensitivitas lain.

2) Klasifikasi Reaksi Alergi

a) Reaksi Hipersensitivitas Segera

Paparan pertama seseorang yang alergi terhadap antigen dapat menginduksi sel T CD4 agar menghasilkan IL4, IL-5, IL-6, IL-10, dan granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). Limfokin akan mengaktifkan limfosit B spesifik masuk ke plasma dan menghasilkan antibodi spesifik alergen-IgE. Selanjutnya bagian Fc berhubungan dengan reseptor afinitas tinggi pada permukaan sel dari sel mast jaringan dan basofil. Reexposure dengan antigen mengikat bagian Fab antibodi IgE

pada permukaan sel mast, menginduksi degranulasi dan pelepasan mediator inflamasi lipid serta sitokin dari sel mast.

b) Reaksi Anafilaktik

Reaksi anafilaksis merupakan respon yang lebih terhadap alergen seperti antibiotik yang dimediasi oleh reaksi tipe I hipersensitivitas. Reaksi ini muncul setelah beberapa menit paparan antigen pada orang yang sangat peka, gejala yang muncul seperti gangguan pernapasan dan syok.

c) Reaksi Anafilaktoid

Reaksi anafilaktoid menyerupai reaksi anafilaksis akan tetapi tidak bergantung pada interaksi antigen bersama antibodi. Obat A bisa saja langsung melepaskan histamin bersumber pada sel mast. Contohnya urtikaria karena pemberian morfin dalam dosis tinggi atau menghidupkan komplemen.

d) Reaksi Alergi terhadap Obat Anestesi

Anafilaksis yang disebabkan oleh obat anestesi umumnya jarang terjadi. Hipersensitivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor resiko seperti jenis kelamin, sejarah atopik, riwayat alergi sebelumnya, dan riwayat penggunaan anestesi sebelumnya.

e) Alergi Lateks

Lateks Alergi lateks merupakan penyebab paling sering kedua selama prosedur anestesi. Paparan kroik lateks dengan riwayat atopi dapat memicu resiko sensitivitas.

f) Alergi Terhadap Antibiotik

Antibiotik pada umumnya menjadi penyebab alergi terbanyak pada pasien yang akan dioperasi, biasanya β laktam antibiotik seperti sefalosporin dan penisilin.

a. Penyakit Penyerta (Past illness)

Pasien yang menjalani prosedur pembedahan akan dikaji riwayat sebelumnya terhadap berbagai penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan paru, penyakit ginjal, penyakit gangguan perdarahan dan lain-lain. Selain itu juga perlu untuk mencari kemungkinan kelainan jantung pada pasien-pasien yang memiliki riwayat hipertensi, menilai kemungkinan dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Selain itu, riwayat operasi dan anestesi sebelumnya dan apakah pasien mengalami komplikasi saat itu.

b. Makan/Minum Terakhir (*Last meal*)

Ketakutan akan aspirasi, dan konsep bahwa semakin lama puasa semakin aman bagi pasien, menyebabkan pembatasan makanan dan

cairan pra operasi yang berlebihan. Berkembangnya pemahaman sejak lama bahwa puasa berlebihan tidak hanya tidak perlu tetapi juga merugikan.

c. Environment

Menanyakan apakah pasien memiliki riwayat merokok dan mengonsumsi alkohol sebelumnya. Serta menanyakan frekuensi dan jumlahnya yang dikonsumsi sehari-hari. Konsumsi alkohol > 30 cc hari dalam 2 minggu sebelum operasi dapat meningkatkan risiko sebesar 20% risiko untuk terjadinya pneumonia dan gagal napas.

Pengkajian AMPLE pra anestesi bertujuan untuk menetapkan status fisik ASA pasien, menentukan jenis operasi yang akan digunakan, memilih teknik anestesi yang sesuai dengan pasien, serta meramalkan penyulit apa yang kemungkinan muncul dan terjadi selama atau sesudah proses pembedahan. Sebelum memberikan tindakan anestesi kita perlu mengetahui pasien yang akan diberi pembiusan apakah memiliki alergi pada obat-obatan yang mungkin akan digunakan selama persiapan operasi sampai post operasi (Dwi Satriyanto & Samosir, 2023).

G. Masalah Preoperasi

Tindakan pembedahan dan anestesi merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Pasien preoperasi akan mengalami reaksi emosional berupa kecemasan. Berbagai alasan yang dapat menyebabkan ketakutan/kecemasan pasien dalam menghadapi pembedahan antara lain :

1. Takut nyeri setelah pembedahan
2. Takut terjadi perubahan fisik, menjadi buruk rupa dan tidak berfungsi normal (body image)
3. Takut keganasan (bila diagnosa yang ditegakkan belum pasti)
4. Takut/cemas mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang mempunyai penyakit yang sama
5. Takut/ngeri menghadapi ruang operasi, peralatan pembedahan dan petugas
6. Takut mati saat dibius/tidak sadar lagi
7. Takut operasi gagal

H. Evaluasi Preoperasi

Evaluasi pra anestesi adalah semua pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi sebelum pasien diberikan anestesi/dilakukan operasi. Empat hal penting yang dievaluasi pada pra anestesi adalah:

1. "*Surgical Disease*" yaitu penyakit yang menyebabkan penderita di operasi.
2. "*Internal Disease*" yaitu penyakit lain yang menyertai *surgical disease*, misalnya : penderita hernia dengan penyakit DM.
3. Kesulitan pemberian anestesi, misalnya kesulitan intubasi atau kesulitan penyuntikan pada analgesia regional.
4. Komplikasi anestesi yang mungkin terjadi baik selama dan sesudah operasi.

Skenario OSCE

1. Setelah mahasiswa membaca materi dengan seksama, mahasiswa diminta untuk melakukan asesmen pra anestesi dan mengisi checklist sesuai dengan format yang terlampir oleh dosen pengampu.

2. Penentuan Klasifikasi ASA

- a. Skenario 1

Pasien laki-laki umur 70 th dengan BPH rencana dilakukan operasi prostatectomy, hasil pemeriksaan TD 150/90 mmHg, nadi 80 x/mnt, RR 28 x/mnt, mempunyai riwayat asma, terakhir serangan 1 bulan yang lalu, riwayat penyakit lain tidak ada, tidak pernah dirawat, hasil laboratorium dalam batas normal, hasil rontgen atherosclerosis, RKG sinus rhytm dalam batas normal. Lakukan penilaian status fisik pasien menurut klasifikasi ASA.

- b. Skenario 2

Pasien perempuan umur 55 th dengan diabetes tipe 1 dibawa ke rumah sakit untuk menjalani *right knee replacement* yang disebabkan oleh osteoarthritis yang dideritanya $\pm$ 20 thn yang lalu. Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, tidak ada abnormalitas pada penglihatan dan juga kardiovaskuler. Gula darah 150 mg/dL, kreatinin 2.0 mg/dL, hasil lab lainnya dalam batas normal. Lakukan penilaian status fisik pasien menurut klasifikasi ASA.

Soal OSCE

1.	No. Stasiun	1
2.	Judul	Pengkajian Praoperasi
3.	Kasus	Persiapan mesin anestesi pada kasus pasien diagnosis fraktur Clavikula Sinistra direncanakan ORIF dengan anestesi umum.
4.	Tujuan	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan implementasi pada tindakan praoperasi
5.	Soal: Skenario dan tugas bagi peserta ujian	SKENARIO Seorang perempuan, 23 tahun, diagnosis fraktur Clavikula Sinistra direncanakan ORIF dengan GA-ETT. Hasil pengkajian: TD 128/80 mmHg, N 90x/menit, RR 18x/menit, SpO2 98%, BB 60 Kg, TB 155 cm. leher pendek, dan mulut kecil. TUGAS 1. Lakukan pengkajian praoperasi sesuai kasus berikut! 2. Buatlah dokumentasi!

6.	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun (interupsi, bertanya, menghentikan, dst) kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE INSTRUKSI KHUSUS 1. Ketika peserta ujian menanyakan diluar dari skenario dialog, penguji akan mengatakan “<u>Tidak ada data</u>”. 2. Ketika peserta uji melakukan pemeriksaan Mallapati, penguji menyampaikan data: Palatum Molle, uvula, fauces terlihat. 3. Beri nilai kertas yang dituliskan hasil pemeriksaan dari peserta ujian. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Tidak ada						
7.	Kebutuhan dan dialog PS	Ada/Tidak ada Deskripsi PS: Seorang perempuan dewasa yang dikondisikan: - Berusia 23 tahun yang terbaring di tempat tidur. - Pundak dan bahu terpasang dibalut perban - Terpasang gelang identitas Pasien - Terpasang infus di salah satu tangan dengan cairan kristaloid Dialog <table><tr><td>Peserta Ujian (PU)</td><td>Pasien Simulasi (PS)</td></tr><tr><td>Mengucapkan salam</td><td>Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja).</td></tr><tr><td>Menanyakan nama dan tanggal lahir</td><td>Menyebutkan nama sendiri, tanggal lahir <u>21 April 2002</u>.</td></tr></table>	Peserta Ujian (PU)	Pasien Simulasi (PS)	Mengucapkan salam	Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja).	Menanyakan nama dan tanggal lahir	Menyebutkan nama sendiri, tanggal lahir <u>21 April 2002</u> .
Peserta Ujian (PU)	Pasien Simulasi (PS)							
Mengucapkan salam	Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja).							
Menanyakan nama dan tanggal lahir	Menyebutkan nama sendiri, tanggal lahir <u>21 April 2002</u> .							

		- Menanyakan riwayat Alergi.	Menjawab semua pertanyaan dengan kata "<u>tidak</u>". Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini.	
		Menanyakan <i>Medication</i> tentang riwayat mengonsumsi obat-obatan rutin jangka panjang	Menjawab mengonsumsi captopril 2 kali sehari. Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini.	
		Menanyakan <i>Past Illness</i> tentang riwayat: - Penyakit sistemik penyerta - Operasi dan anestesi sebelumnya	Menjawab ada penyakit penyerta hipertensi sejak 2 tahun lalu. Apabila ditanya riwayat operasi, peserta menjawab Belum pernah menjalani operasi dan anestesi sebelumnya. Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini.	
		Menanyakan <i>Last Meal</i> tentang riwayat terakhir mengonsumsi makanan dan minuman.	Menjawab terakhir makan nasi dan minum 6 jam yang lalu, saat ini puasa.	
		Menanyakan <i>events</i> tentang riwayat: - Mengonsumsi alkohol. - Merokok. - Menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama.	Menjawab semua pertanyaan dengan kata "<u>tidak</u>". Catatan: Tidak perlu dijawab diluar pertanyaan ini.	

		Melakukan pemeriksaan fisik LEMON (Mallapati) - Meminta pasien untuk membuka mulut - Melihat palatum durum - Melihat palatum mole - Melihat uvula - Melihat pilar laring - Menilai score mallapati Pasien diam tidak memberikan reaksi.												
		Catatan: Ketika peserta ujian menanyakan diluar dari skenario dialog, PS diam saja dan penguji akan mengatakan "<u>Tidak ada data</u>".												
8.	Kebutuhan manekin, alat dan BHP	<table><tr><td>No.</td><td>Alat dan Bahan</td><td>Jumlah*</td></tr><tr><td>1.</td><td>Troli</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sarung tangan bersih</td><td>Sesuai jumlah peserta dan 2 cadangan</td></tr><tr><td>3.</td><td><i>Stetoscope</i></td><td>1 buah</td></tr></table> *Catatan: - Bahan habis pakai disesuaikan jumlah peserta dalam satu putaran + Cadangan (jumlah peserta dalam 1 putaran/sesi + 20%)	No.	Alat dan Bahan	Jumlah*	1.	Troli	1 buah	2.	Sarung tangan bersih	Sesuai jumlah peserta dan 2 cadangan	3.	<i>Stetoscope</i>	1 buah
No.	Alat dan Bahan	Jumlah*												
1.	Troli	1 buah												
2.	Sarung tangan bersih	Sesuai jumlah peserta dan 2 cadangan												
3.	<i>Stetoscope</i>	1 buah												
10.	Kebutuhan laboran	Tidak ada.												
11.	Penulis	TIM												

DOPS

Format *Direct Observational Procedural Skills* (DOPS)

Nama :

Tanggal :

Tempat :

Kasus

Setting kasus : O Rawat jalan/ poli O rawat Inap (dicentang salah satu)

Kasus ke : Pengkajian Praoperasi

Penilai

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik).

Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5.

1. Penyampaian *informed consent*

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

2. Persiapan sebelum pemeriksaan

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait dan teknik prosedur

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

4. Kemampuan teknis

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

5. Teknik aseptik

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

6. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

7. Manajemen kasus

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

8. Ketrampilan komunikasi

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

9. Profesionalisme penanganan pasien

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

10. Kemampuan Umum untuk tindakan secara keseluruhan

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

I. Ringkasan

Pengkajian praoperasi dan persiapan pasien merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan data fisik, psikologis, dan sosial sebelum operasi guna mengidentifikasi risiko anestesi, komorbid, perdarahan, serta infeksi, sekaligus memastikan kesiapan pasien melalui kompetensi seperti CPL/CPMK yang mencakup etika anestesi, klasifikasi ASA (I-VI), pemeriksaan LEMON (Look externally, Evaluate thyromental, Mallampati, Obstruction/obesity, Neck mobility) untuk prediksi intubasi sulit, dan AMPLE (Allergies, Medication, Past illness, Last meal, Environment), termasuk persiapan penunjang (lab, EKG, radiologi), informed consent, premedikasi (diazepam, antibiotik profilaksis), dukungan mental keluarga, edukasi (nafas dalam, manajemen nyeri), serta evaluasi cemas pasien untuk mengurangi komplikasi dan mendukung pemulihan perioperatif.

Glosarium

Alergi : Reaksi berlebihan sistem imun tubuh terhadap zat tertentu seperti obat, makanan, atau bahan lain yang dianggap berbahaya.

AMPLE : Metode pengkajian praoperasi yang meliputi Allergies, Medication, Past Illness, Last Meal, dan Environment.

Anestesi : Tindakan menghilangkan rasa nyeri atau kesadaran sementara untuk keperluan pembedahan atau prosedur medis.

Antibiotik Profilaksis : Antibiotik yang diberikan sebelum operasi untuk mencegah terjadinya infeksi.

ASA (American Society of Anesthesiologists) : Sistem klasifikasi status fisik pasien untuk menilai risiko anestesi sebelum operasi.

Clotting Time : Waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku.

ECG/EKG (Elektrokardiografi) : Pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung.

Evaluasi Praoperasi : Penilaian menyeluruh terhadap kondisi pasien sebelum menjalani pembedahan dan anestesi.

Hemoglobin : Protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Hidrasi : Kondisi kecukupan cairan tubuh.

Hipertensi : Tekanan darah tinggi yang melebihi batas normal.

Informed Consent : Persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien atau keluarga setelah mendapat penjelasan lengkap.

Intubasi : Tindakan memasukkan pipa ke jalan napas untuk membantu pernapasan selama anestesi.

Komorbid : Penyakit penyerta yang dimiliki pasien selain penyakit utama.

LEMON : Metode pemeriksaan jalan napas sebelum anestesi yang meliputi Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction/Obesity, Neck mobility.

Mallampati : Penilaian anatomi rongga mulut untuk memprediksi kesulitan intubasi.

Nutrisi : Asupan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pemulihan.

Perioperatif : Masa keseluruhan yang meliputi sebelum, saat, dan sesudah operasi.

Premedikasi : Obat yang diberikan sebelum anestesi untuk menenangkan pasien atau mempersiapkan tindakan operasi.

Preoperasi : Masa persiapan sebelum tindakan operasi dilakukan.

Pulse Oximeter : Alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan denyut nadi.

Radiologi : Pemeriksaan penunjang menggunakan sinar-X, CT scan, atau pencitraan lainnya.

Status Fisik : Kondisi kesehatan umum pasien yang dinilai sebelum tindakan medis.

Tensimeter : Alat untuk mengukur tekanan darah.

Referensi

- Dwi Satriyanto, M., & Samosir, I. (2023). Perioperative Anesthesia for TURP in Geriatric patient with Anodontia. *Collaborative Medical Journal*, 6(3), 1–5.
- Lyvia, L., Hutagaol, B., Sebayang, S. M., & Ningrum, E. W. (2025). Gambaran Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa Keperawatan Anesthesiologi Tentang Pemeriksaan LEMON pada Pra Anestesi. *Khatulistiwa Jurnal Nursing*, 7(2), 12–21. <https://doi.org/10.53399/knj.v7i2.paperID>
- Ma, W., Liu, Y., Liu, J., Qiu, Y., & Zuo, Y. (2024). Prehabilitation of surgical patients : a bibliometric analysis from 2005 to 2023. *Perioperative Medicine*, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13741-024-00410-x>
- Nicolaus Trijoko, P. (2024). Jarak Tiromental Dan Mallampati Skor Dengan Kesulitan Intubasi Pada Pasien General Anestesi Di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. *Jurnal Inovasi Global*, 2(10), 1468–1480.
- Putra Fratama, A., Hamdi, T., & Fauzi Tanjung, Q. (2024). Correlation Analysis of Lemon, IDS, and Wilson Scores in Assessing Intubation Difficulty in Patients Undergoing General Anesthesia. *Journal Of Society Medicine*, 3(8), 3–9.

BAB 3

MANAJEMEN KECEMASAN DAN EDUKASI PRAOPERASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan perioperatif, alur pelayanan bedah, patient safety, etika–legal, dan pencegahan infeksi sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian praoperasi, identifikasi risiko, dan persiapan pasien secara sistematis serta terdokumentasi.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan perioperatif (pra–intra–pasca) berbasis data untuk menetapkan prioritas masalah dan rencana asuhan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan intervensi perioperatif untuk keselamatan pembedahan (infeksi, posisi, skin integrity, transfusi, monitoring) sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu melaksanakan asuhan pascabedah (PACU, nyeri, PONV, komplikasi, perawatan luka) secara aman dan terukur.	CPMK-5; CPMK-4
CPL-6	Mampu berkomunikasi efektif dalam tim bedah, menggunakan checklist dan dokumentasi, serta melakukan discharge planning dan perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan perioperatif, keselamatan pasien, etika–legal, dan prinsip pencegahan infeksi dalam pelayanan bedah.
CPMK-2	Melakukan pengkajian praoperasi, identifikasi risiko (komorbid, anestesi, perdarahan, infeksi), serta persiapan pasien dan dokumentasinya secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data praoperasi dan intraoperatif untuk merumuskan diagnosis/prioritas masalah serta tujuan asuhan perioperatif yang terukur.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi perioperatif (edukasi, manajemen kecemasan, pencegahan infeksi, posisi, cairan–perdarahan) sesuai standar dan keamanan.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pasca anestesi dan pascabedah (PACU, nyeri, PONV, pencegahan komplikasi, perawatan luka/drain/stoma) dengan evaluasi terukur.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pembedahan melalui kolaborasi tim, surgical safety checklist, monitoring intraoperatif, serta keselamatan transfusi dan perangkat.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran perioperatif, menyusun dokumentasi dan handover, serta discharge planning dan refleksi perbaikan mutu berbasis indikator.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Manajemen Kecemasan dan Edukasi Praoperasi	3.1 Menilai tingkat kecemasan dan kebutuhan informasi pasien/keluarga praoperasi.	3.2 Melaksanakan edukasi praoperasi dan teknik manajemen kecemasan dengan evaluasi pemahaman terukur.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian praoperasi + checklist	Kelengkapan item pengkajian risiko dan ketepatan persiapan praoperasi terdokumentasi (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; lembar praoperasi
CPMK-4	Skill station aseptik-posisi-edukasi + checklist	Ketepatan praktik aseptik/posisi aman dan kualitas edukasi (teach-back) dengan indikator terukur.	15	Checklist keterampilan; materi edukasi
CPMK-7	Portofolio handover-discharge plan + laporan kasus	Kelengkapan handover/discharge plan (skor checklist) dan kualitas evaluasi luaran berbasis indikator.	15	Handover; discharge plan; laporan kasus

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep keselamatan perioperatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan keputusan etika-PPI pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan pengkajian praoperasi (checklist)	≤60% item terpenuhi; ada item kritis terlewat	61–75% terpenuhi; kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.2 Ketepatan persiapan pasien & dokumentasi	Banyak komponen hilang/keliru	Komponen inti ada; masih ada kekurangan	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap, ringkas, dapat diaudit

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah terhadap data kasus	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung; inkonsisten	Sebagian besar didukung data relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat & konsisten
3.2 Keterukuran tujuan/luaran & rasional	Tujuan tidak terukur; rasional lemah	Tujuan umum; rasional terbatas	Tujuan terukur; rasional jelas	Tujuan sangat terukur; rasional kuat (≥ 2 alasan/sumber kredibel)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan praktik aseptik/posisi aman (checklist)	$\leq 60\%$ langkah benar; risiko tinggi	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	$> 90\%$ benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Kualitas edukasi pra/intra (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan asuhan PACU (stabilitas & kriteria transfer)	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Sangat tepat; cepat, aman, terdokumentasi lengkap
5.2 Ketepatan manajemen nyeri/PONV & perawatan luka/drain	Tidak sesuai; evaluasi respons tidak ada	Cukup sesuai; evaluasi terbatas	Sesuai; evaluasi respons jelas	Sangat sesuai; evaluasi komprehensif & pencegahan komplikasi kuat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan surgical safety checklist (fase lengkap)	Banyak item kritis tidak dilakukan	Item inti dilakukan; masih ada kekurangan	Hampir semua item dilakukan konsisten	Semua item dilakukan konsisten; deviasi terdeteksi cepat
6.2 Ketepatan keselamatan transfusi (verifikasi & monitoring)	Verifikasi keliru; monitoring tidak adekuat	Verifikasi cukup; monitoring kurang konsisten	Verifikasi tepat; monitoring adekuat	Verifikasi sangat tepat; monitoring komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan handover/discharge plan (checklist)	Banyak informasi kritis hilang	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; mudah ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi
7.2 Evaluasi luaran berbasis indikator & rencana tindak lanjut	Tanpa indikator; tindak lanjut tidak jelas	Indikator terbatas; tindak lanjut umum	Indikator memadai; tindak lanjut spesifik	Indikator komprehensif; tindak lanjut spesifik, terukur, realistis

A. MANAJEMEN KECEMASAN**1. Pengertian Kecemasan Praoperasi**

Kecemasan menurut American Psychological Association (2018) didefinisikan sebagai emosi yang ditandai dengan perasaan khawatir disertai gejala fisik seperti ketegangan. Kecemasan yang muncul pada seorang individu dapat diartikan emosional negatif yang bisa dirasakan oleh manusia dengan munculnya perasaan dan pikiran yang tegang, kekhawatiran dan biasanya disertai dengan gejala detak jantung kuat, berkeringat, dan sesak nafas (Nisa & Rosyid, 2023). Individu yang mengalami kecemasan cenderung mengantisipasi adanya bahaya, bencana, atau hal buruk yang akan terjadi. Dalam kondisi ini, tubuh merespons dengan meningkatkan kesiagaan, seperti otot menjadi tegang, pernapasan lebih cepat, dan denyut jantung meningkat. Kecemasan berbeda dengan ketakutan, meskipun keduanya sering dianggap sama. Kecemasan bersifat berorientasi pada masa depan, berlangsung lebih lama, dan berkaitan dengan ancaman yang tidak jelas. Sementara itu, ketakutan merupakan respon terhadap ancaman yang nyata, terjadi saat ini, dan bersifat sementara.

Intervensi yang tepat sangat diperlukan untuk mempersiapkan pasien dari segi fisik dan psikologis sebelum dilakukan pembedahan. Intervensi yang dimaksud yaitu seperti pemberian obat premedikasi, terapi farmakologi dan non farmakologi, penyediaan informasi, distraksi, pemusatan perhatian dan prosedur relaksasi.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecemasan

Kecemasan yang dialami oleh pasien yang akan dilakukan pembedahan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Menurut Nuraini et al., (2023) disebutkan ada beberapa faktor yang memengaruhi kecemasan pada pasien praoperasi, diantaranya umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

a. Umur

Sebagian pendapat menyatakan bahwa individu yang berusia lebih muda cenderung lebih mudah mengalami stres dibandingkan dengan individu yang lebih tua, namun ada pula pandangan yang menyebutkan sebaliknya. Pada usia muda, kecemasan atau stres sering muncul karena berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menumpuk dan memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Meskipun demikian, pengaruh usia terhadap kecemasan tidak selalu dapat ditentukan secara pasti, karena banyak individu melaporkan telah mengalami kecemasan sejak lama atau sejak mereka dapat mengingatnya. Secara umum, kecemasan sering dilaporkan terjadi pada rentang usia antara 17 hingga 65 tahun. Faktor usia juga dapat memengaruhi tingkat kecemasan pasien sebelum menjalani tindakan pembedahan. Pasien yang lebih muda sering kali menunjukkan kecemasan yang lebih tinggi karena kurangnya pengalaman menghadapi prosedur medis, kekhawatiran terhadap proses anestesi, serta ketidakpastian mengenai hasil operasi yang akan dijalani. Sebaliknya, pasien yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak sehingga cenderung lebih mampu mengendalikan respons emosional ketika menghadapi situasi tersebut.

b. Jenis Kelamin

Perempuan cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecemasan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini berkaitan dengan perbedaan dalam cara mengekspresikan dan merespons emosi, di mana perempuan umumnya lebih sensitif terhadap perubahan emosional dan lebih sering menggunakan pendekatan emosional dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kondisi tersebut dapat membuat perempuan lebih mudah merasakan kekhawatiran atau ketegangan ketika menghadapi situasi yang

menekan. Dalam konteks praoperasi, perempuan sering menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi karena adanya kekhawatiran terhadap prosedur pembedahan, proses anestesi, kemungkinan rasa nyeri, serta hasil dari tindakan operasi yang akan dijalani. Selain itu, faktor biologis, psikologis, dan peran sosial yang dimiliki perempuan juga dapat memengaruhi cara mereka merespons situasi stres, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kecemasan sebelum menjalani tindakan operasi.

c. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pula pengetahuan dan pemahamannya terhadap berbagai informasi serta konsep yang dihadapi. Pendidikan yang lebih tinggi juga biasanya disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan analisis yang lebih baik, sehingga individu mampu membentuk persepsi yang lebih positif terhadap suatu situasi. Selain itu, tingkat pendidikan yang memadai dapat membantu seseorang lebih mudah mengenali sumber stres, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Pasien dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya lebih mudah memahami informasi mengenai prosedur operasi, proses anestesi, serta persiapan yang harus dilakukan. Pemahaman tersebut dapat membantu pasien mengelola kecemasan dengan lebih baik karena mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih cukup terhadap tindakan medis yang akan dijalani.

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan sangat penting agar tenaga kesehatan dapat memberikan pendekatan dan intervensi yang tepat dalam membantu pasien mengelola kecemasan yang dialaminya.

3. Dampak Kecemasan

Kecemasan dapat memberikan berbagai dampak terhadap kondisi psikologis maupun fisiologis seseorang. Dampak yang ditimbulkan bisa dilihat dari segi psikologis, fisiologis, kognitif, dan afektif.

a. Dampak Psikologis

Perasaan cemas dapat muncul melalui berbagai tanda dan gejala, seperti munculnya firasat buruk, rasa takut terhadap pikiran sendiri, mudah tersinggung, perasaan tegang, tidak tenang, gelisah, serta mudah terkejut. Selain itu, kecemasan juga dapat memengaruhi pola tidur, misalnya munculnya mimpi yang menegangkan, serta menurunnya kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Dari sisi fisik, kecemasan juga dapat menimbulkan berbagai keluhan somatik seperti nyeri pada otot dan tulang, jantung berdebar, sesak napas, gangguan pencernaan, sakit kepala, gangguan buang air kecil, serta

tangan yang terasa dingin dan lembap. Pada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan, gejala-gejala tersebut dapat berdampak pada kondisi psikologis pasien, seperti meningkatnya rasa takut, ketidakpastian, dan kekhawatiran terhadap prosedur operasi maupun hasil tindakan yang akan dijalani. Dampak psikologis ini dapat memengaruhi kesiapan mental pasien sebelum operasi serta memengaruhi kemampuan pasien dalam menerima informasi dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan selama proses perawatan. Oleh karena itu, penanganan kecemasan menjadi penting untuk membantu pasien merasa lebih tenang dan siap menghadapi tindakan pembedahan.

b. Dampak Fisiologis

Kecemasan juga dapat menimbulkan berbagai perubahan pada respon fisiologis tubuh pada berbagai sistem tubuh.

- 1) Sistem kardiovaskular, kecemasan dapat ditandai dengan munculnya palpitasi atau jantung berdebar, peningkatan maupun penurunan tekanan darah, serta perubahan denyut nadi.
- 2) Sistem pernapasan, individu dapat mengalami napas yang lebih cepat, pendek, dangkal, atau terasa terengah-engah.
- 3) Sistem gastrointestinal, kecemasan dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, rasa tidak nyaman pada perut, mual, hingga diare.
- 4) Sistem neuromuskular, gejala yang dapat muncul antara lain tremor, rasa gugup, gelisah, gangguan tidur atau insomnia, serta pusing.
- 5) Traktus urinarius, kecemasan dapat menyebabkan keinginan untuk berkemih lebih sering, dan pada kulit dapat muncul keringat dingin, rasa gatal, serta wajah tampak kemerahan.

Pada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan, berbagai respon fisiologis tersebut sering muncul sebagai akibat dari kecemasan yang dialami sebelum operasi. Perubahan fisiologis ini dapat memengaruhi kondisi tubuh pasien, seperti peningkatan tekanan darah dan frekuensi nadi yang dapat berdampak pada kestabilan kondisi pasien sebelum tindakan anestesi dan pembedahan dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan kecemasan pada fase praoperasi menjadi penting untuk membantu menjaga stabilitas kondisi fisiologis pasien sehingga tindakan operasi dapat berlangsung dengan lebih aman.

c. Dampak Kognitif

Kondisi kecemasan juga berdampak pada aspek kognitif. Dimana perubahan pada aspek ini dapat memengaruhi cara seseorang dalam memproses informasi, mengambil keputusan, dan merespon situasi yang

dihadapi. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa gangguan pada fokus perhatian, penurunan kemampuan memori yang ditandai dengan mudah lupa, kekeliruan dalam menilai situasi, serta hambatan dalam proses berfikir. Seorang individu tersebut juga dapat mengalami peningkatan kesadaran diri yang berlebihan, kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi, serta ketidakmampuan dalam membuat keputusan. Selain itu dapat menyebabkan menyempitnya persepsi dan menurunnya kreativitas, disertai perasaan bingung, takut, serta hilangnya kendali diri.

d. Dampak Afektif

Dampak lain yang ditimbulkan dari kecemasan ini yaitu pada aspek afektif atau emosional individu. Perubahan pada aspek ini mencerminkan bagaimana seseorang merasakan, mengekspresikan, dan mengendalikan emosinya dalam menghadapi situasi tertentu.

4. Tingkat Kecemasan

Munculnya kecemasan merupakan pengalaman yang umum dialami oleh setiap individu ketika dihadapkan dengan situasi yang dianggap mengancam. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ketika berlangsung secara terus menerus dan dirasakan secara berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai tingkat kecemasan agar individu dapat mengenali kondisi dan menentukan upaya penanganan yang tepat. Kecemasan menurut teori Stuart & Sudeen, (2016) dikategorikan menjadi empat tingkatan, yaitu ringan, sedang, berat, dan panik.

a. Kecemasan Ringan

Kecemasan ini merupakan tingkat ketegangan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membuat seseorang menjadi lebih waspada sehingga persepsinya menjadi meluas. Kondisi ini membuat seseorang termotivasi untuk belajar dan memecahkan masalah secara efektif serta mendorong pertumbuhan dan kreativitas. Cemas ringan ditandai dengan terlihat tampak tenang dan percaya diri, lebih waspada, memperhatikan banyak hal, sedikit tidak sabar, ketegangan otot ringan, sadar lingkungan, rileks atau sedikit gelisah.

b. Kecemasan Sedang

Kecemasan tingkat sedang dimana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja, hanya fokus pada satu pikiran yang menjadi pusat perhatiannya dan mengesampingkan hal lain yang bukan menjadi prioritas. Kecemasan ini ditandai dengan menurunnya perhatian, menurunnya penyelesaian masalah, tidak sabar, mudah tersinggung, hemodinamik

meningkat, ketegangan otot sedang, mondar mandir, sering berkemih, dan sakit kepala.

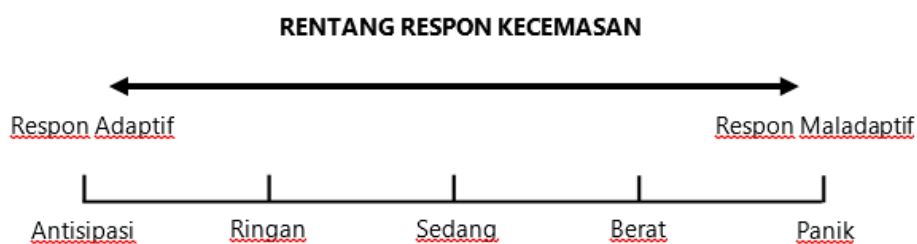
c. Kecemasan Berat

Kecemasan berat membuat individu cenderung hanya berfokus pada hal-hal yang rinci dan sulit memikirkan hal lain. Seluruh perilaku diarahkan untuk mengurangi kecemasan, serta memerlukan banyak informasi dan arahan agar dapat mengalihkan perhatian ke aspek lainnya. Pada kondisi ini seorang individu cenderung sulit berpikir, penyelesaian masalah yang buruk, banyak keringat, bicara cepat, menggertakkan gigi, rahang menegang, mondari mandir dan merasa gemetar.

d. Panik

Panik merupakan tingkat kecemasan yang paling tinggi. Kecemasan yang muncul berhubungan dengan terror dan ketakutan yang berlebih sehingga individu kehilangan kendali. Kondisi ini dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, menghilangnya pemikiran yang rasional, dan munculnya persepsi yang menyimpang.

Kecemasan yang dialami individu dampaknya tidak selalu sama, melainkan berada dalam suatu rentang respon yang bervariasi. Rentang respon kecemasan menggambarkan bagaimana individu tersebut merespon stres atau ancaman yang dihadapinya. Dibedakan menjadi dua respon, yaitu respon adaptif dan maladaptif.



Gambar 3. 1 Rentang Respon Kecemasan (Stuart & Sudeen, (2016)

a. Respon Adaptif

Respon adaptif merupakan respon positif yang didapatkan ketika seorang individu mampu menerima dan mengatur kecemasan yang dirasakannya. Strategi koping yang digunakan untuk mengelola kecemasan seperti menangis, berbagi cerita dengan orang lain, istirahat atau tidur, olahraga, dan menerapkan berbagai teknik relaksasi.

b. Respon Maladaptif

Respon maladaptif merupakan respon yang didapatkan ketika seorang individu sudah tidak dapat mengontrol kecemasannya. Berbagai jenis coping maladaptif seperti, melakukan tindak kekerasan, minum alkohol, bicara tidak jelas, berjudi, isolasi diri, dan mengonsumsi obat terlarang.

5. Alat Ukur Kecemasan

Beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kecemasan antara lain:

a. *Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS)*

Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat kecemasan pada pasien yang akan menjalani operasi. APAIS merupakan alat ukur yang telah divalidasi, diterima, dan diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa. Terdapat tiga komponen yang dinilai yaitu kecemasan tentang anestesi, operasi, dan keinginan untuk informasi. Hasil ukur dari instrumen ini diklasifikasikan menjadi tidak ada kecemasan (1-6), cemas ringan (7-12), cemas sedang (13-18), cemas berat (19-24), dan cemas berat sekali/panik (25-30). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen APAIS versi Indonesia menunjukkan bahwa alat ukur tersebut dinyatakan valid dan reliabel dalam menilai tingkat kecemasan praoperasi pada populasi Indonesia, dengan nilai Cronbach Alpha pada komponen kecemasan sebesar 0,825 dan 0,863 (Firdaus, 2014).

b. *State-Trait Anxiety Inventory (STAI)*

STAI merupakan instrumen yang umum digunakan untuk mengukur kecemasan berdasarkan dua dimensi, yaitu kondisi sementara (*state*) dan sifat bawaan individu (*trait*). Alat ini bermanfaat untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan yang sedang dirasakan saat ini (*state*) sekaligus kecemasan yang bersifat menetap atau jangka panjang (*trait*). Skor STAI dilakukan dengan cara menilai tiap soal untuk menghasilkan jumlah skor 0-60 untuk masing-masing kategori. Reliabilitas kuesioner ini 0,89 dan validitasnya 0,73.

c. *Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)*

Skala HARS merupakan alat ukur kecemasan yang didasarkan pada munculnya gejala-gejala pada individu yang mengalami kecemasan. Skala ini diciptakan oleh Max Hamilton dimana terdiri dari 14 pertanyaan yang mengidentifikasi berbagai aspek kecemasan. Aspek penilaian tersebut terdiri dari ketakutan, kecemasan, kegelisahan/ketegangan, optimisme, kesedihan/depresi, intelektual, minat, otot/somatik, insomnia, kardiovaskuler, pernafasan, perkemihan, gastrointestinal, dan perilaku. Hasil ukur dari instrumen ini diklasifikasikan menjadi tidak ada kecemasan (<14), cemas

ringan (14-20), cemas sedang (21-27), cemas berat (28-41), dan cemas berat sekali (42-56).

d. *Depression Anxiety Stress Scale (DASS)*

Instrumen ini digunakan untuk menentukan derajat kecemasan pasien dengan 42 aspek penilaian. Dari 42 aspek tersebut, terdapat 3 skala diantaranya, skala depresi pada aspek penilaian, aspek skala kecemasan, dan aspek skala stress.

6. Manajemen Kecemasan

Manajemen kecemasan praoperasi merupakan suatu upaya untuk mengendalikan kecemasan yang berlebihan atau mengganggu sebelum tindakan pembedahan dilakukan. Tujuan dari manajemen ini bukan untuk menghilangkan kecemasan sepenuhnya, melainkan untuk menurunkannya agar tidak menghambat jalannya prosedur operasi. Manajemen kecemasan dapat dilakukan melalui pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis.

a. Penatalaksanaan Farmakologi

Terapi farmakologi untuk kecemasan adalah penggunaan obat-obatan untuk mengurangi gejala kecemasan, seperti rasa takut berlebihan, gelisah, dan ketegangan. Terapi ini biasanya digunakan pada kecemasan sedang hingga berat, atau ketika terapi non-farmakologis saja tidak cukup. Obat pilihan untuk mengatasi gangguan cemas menyeluruh adalah obat golongan benzodiazepin. Pemberian obat golongan benzodiazepin dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemberian dosis terendah dinaikan secara berkala sesuai kebutuhan. Contohnya yaitu diazepam, lorazepam, midazolam, alprazolam. Obat anti kecemasan non-benzodiazepine, seperti buspiron (Buspar) dan berbagai antidepresan juga digunakan.

b. Penatalaksanaan Non Farmakologi

1) Distraksi

Distraksi merupakan salah satu metode untuk mengurangi kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pasien ke hal lain, sehingga rasa cemas dapat berkurang. Stimulus sensori yang menyenangkan dapat memicu pelepasan endorfin yang berperan menghambat rangsangan kecemasan, sehingga lebih sedikit impuls cemas yang diteruskan ke otak. Terapi nonfarmakologis bertujuan untuk meningkatkan respons adaptif pasien, salah satunya melalui teknik distraksi, seperti penggunaan media audiovisual (misalnya film kartun). Menurut hasil penelitian Dwairej et al., (2018) distraksi dengan video efektif, efisien waktu dan aman digunakan dalam menurunkan kecemasan anak praoperasi pada bedah rawat jalan dengan anestesi umum. Penelitian lain menurut Ningrat et al., (2026)

pemberian edukasi menggunakan media audiovisual animasi *motion graphic* efektif menurunkan tingkat kecemasan pasien preoperasi sectio caesarea dengan anestesi spinal. Penggunaan media audiovisual sebagai metode edukasi nonfarmakologis yang praktis, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kesiapan mental pasien sebelum tindakan operasi.

2) Teknik relaksasi

Terapi relaksasi yang dapat diterapkan meliputi meditasi, imajinasi dan visualisasi, serta relaksasi progresif. Relaksasi berkaitan dengan pemanjangan serabut otot rangka, sedangkan ketegangan terjadi akibat kontraksi serabut otot tersebut. Menurut hasil penelitian Pratiwi & Samiasih (2022), pemberian Relaksasi Benson efektif untuk menurunkan skala kecemasan pasien pre operasi bedah mulut *Gingivectomy*. Relaksasi Benson efektif menciptakan kondisi tenang dan rileks dengan memperlambat aktivitas gelombang otak. Proses ini terjadi saat individu mengikuti teknik relaksasi seperti mengendurkan otot dan memejamkan mata, sehingga ketegangan tubuh berkurang dan muncul rasa nyaman.

B. EDUKASI PRAOPERASI

1. Pengertian Edukasi Praoperasi

Edukasi merupakan proses belajar dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Edukasi kesehatan yang diberikan kepada pasien memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Edukasi ini merupakan proses penyampaian pengetahuan atau pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam merawat dirinya sendiri, serta membantu pasien mengembangkan perilaku baru dalam menghadapi masalah kesehatannya. Selain itu, edukasi pasien juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan keselamatan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Edukasi praoperasi merupakan proses penyampaian informasi yang mencakup penjelasan mengenai prosedur operasi, persiapan sebelum tindakan, hingga perawatan setelah operasi. Edukasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pasien secara fisik, psikologis, dan sosial agar mampu menjalani prosedur operasi dengan aman dan optimal. Edukasi praoperasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses komunikasi dua arah yang memungkinkan pasien memahami kondisi kesehatannya, prosedur yang akan dilakukan, serta perawatan yang akan dijalani setelah operasi. Edukasi ini

bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kecemasan pasien yang akan menjalani pembedahan.

Edukasi yang efektif membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, prosedur yang akan dijalani, serta tindakan lanjutan yang perlu dilakukan. Pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepercayaan, keterlibatan, dan kenyamanan pasien dalam menerima layanan kesehatan.

2. Tujuan Edukasi Praoperasi

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien

Informasi yang diberikan mengenai diagnosis, prosedur operasi, anestesi serta tahapan yang akan dilalui dengan jelas dan rinci dapat meningkatkan pemahaman yang baik bagi pasien dan keluarga. Melalui pemahaman yang baik pasien dapat mengetahui alasan tindakan dilakukan, proses sebelum selama dan setelah operasi, serta mengurangi kesalahpahaman terkait tindakan medis. Dengan begitu, pasien yang teredukasi cenderung lebih kooperatif dan mampu mengikuti instruksi tenaga kesehatan dengan baik.

b. Mengurangi kecemasan

Ketidaktahuan sering menjadi penyebab utama munculnya rasa takut terhadap operasi. Sehingga edukasi praoperasi menjadi salah satu tujuan utama untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien. Melalui edukasi pasien dapat memiliki gambaran yang jelas tentang prosedur operasi, ketidakpastian dapat diminimalkan, dan pasien merasa lebih siap secara mental. Penurunan kecemasan ini juga berdampak positif pada kondisi fisiologis, seperti hemodinamik menjadi lebih stabil.

c. Mempersiapkan kondisi fisik dan mental

Persiapan praoperasi tidak hanya fokus pada kondisi tubuh, tetapi juga kesiapan mental pasien. Keduanya sangat penting untuk menurunkan risiko komplikasi dan meningkatkan keberhasilan tindakan operasi, terutama pada prosedur dengan anestesi.

d. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pasien

Edukasi mendorong pasien untuk aktif terlibat dalam proses perawatan. Pasien tidak hanya menjadi objek tindakan, tetapi juga subjek yang berperan dalam keberhasilan terapi.

e. Mencegah komplikasi perioperatif

Edukasi praoperasi membantu pasien memahami dan mematuhi instruksi medis seperti puasa sebelum operasi, persiapan fisik, serta Latihan mobilisasi, sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi seperti aspirasi, infeksi luka operasi, gangguan respirasi, serta komplikasi kardiovaskular selama dan setelah tindakan operasi.

f. Meningkatkan keselamatan pasien

Melalui edukasi, pasien menjadi lebih sadar terhadap prosedur yang akan dijalani, risiko yang mungkin terjadi, serta peran aktif yang harus dilakukan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan komunikasi dengan tenaga kesehatan, dan mendukung penerapan prinsip keselamatan pasien selama proses perioperatif.

g. Mempercepat proses pemulihan pasca operasi

Edukasi membekali pasien dengan pengetahuan tentang manajemen nyeri, pentingnya mobilisasi dini, latihan pernapasan, dan perawatan luka, sehingga pasien dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan, mengurangi komplikasi, dan mempercepat kembalinya fungsi tubuh secara optimal.

h. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan

Edukasi praoperasi membantu pasien memahami alur tindakan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan rasa percaya terhadap tenaga kesehatan, sehingga pasien merasa lebih nyaman, dihargai, dan terlibat dalam proses perawatan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

3. Materi Edukasi Praoperasi

Materi edukasi praoperasi harus disusun secara sistematis, sederhana, dan sesuai kebutuhan pasien. Materi yang diberikan meliputi:

a. Informasi prosedur operasi

Materi ini mencakup jenis operasi yang akan dilakukan, tujuan dan manfaat operasi, tahapan prosedur, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tujuan pemberian materi ini agar dapat memberikan pemahaman yang jelas sehingga pasien tidak mengalami ketakutan akibat ketidaktahuan. Hasil penelitian Alsufyani et al., (2024) menunjukkan bahwa pemberian edukasi preoperasi yang tepat mengenai tindakan *sectio caesarea* dapat menurunkan kecemasan sebelum operasi, meningkatkan hasil perawatan pasien, serta mendorong keterlibatan pasien dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan.

b. Penjelasan tentang anestesi

Edukasi tentang anestesi meliputi jenis anestesi (umum, regional), prosedur pemberian anestesi, efek samping yang mungkin terjadi, dan proses pemulihan pasca anestesi. Pemberian edukasi menggunakan media video mengenai prosedur anestesi dapat meningkatkan pengetahuan serta membentuk perubahan sikap pasien menjadi lebih baik terhadap tindakan anestesi. Selain itu, penggunaan media video juga dinilai efektif dalam

menurunkan tingkat kecemasan pasien pre-anestesi yang akan menjalani operasi elektif (Sari et al., 2024).

c. Persiapan Fisik

Persiapan fisik meliputi puasa, kebersihan diri, penghentian obat tertentu, pelepasan aksesoris dan pemeriksaan penunjang. Persiapan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko komplikasi selama operasi.

d. Latihan praoperasi

Pasien diajarkan latihan seperti teknik relaksasi napas dalam, *guided imagery*, batuk efektif, dan latihan mobilisasi untuk mengurangi tingkat nyeri, kecemasan, dan mencegah komplikasi. Menurut Anamagh et al., (2024) penerapan intervensi non-farmakologis seperti *guided imagery* dalam perawatan perioperatif memiliki potensi dalam menurunkan kecemasan dan meningkatkan kenyamanan pasien, sehingga dapat memperbaiki hasil perawatan. Hasil dari tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa teknik *guided imagery* merupakan intervensi yang efektif dalam menurunkan kecemasan perioperatif pada pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit.

e. Perawatan pasca operasi

Materi mencakup manajemen nyeri, perawatan luka, mobilisasi dini, serta penanganan komplikasi pasca operasi dengan tujuan mempersiapkan pasien untuk proses pemulihan.

4. Jenis Media Edukasi

a. Media cetak

Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah booklet, leaflet, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), *flashcard*, rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, stiker, pamflet, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Penelitian Ramadhani et al., (2025) menyimpulkan penggunaan media edukasi buku saku memberikan pengaruh terhadap pengetahuan keluarga pasien preoperasi dimana dengan desain yang menarik, cetakan penuh warna, deskripsi isi materi yang singkat dan jelas pada buku saku dapat meningkatkan kualitas hasil bacaan. Hasil penelitian Purnamasari et al., (2025) menunjukkan edukasi berbasis digital tentang *self healing* dapat memberikan pengaruh terhadap *quarter life crisis* pada mahasiswa. Dalam kehidupan manusia di era digital saat ini tidak akan terlepas dari teknologi sehingga model edukasi yang menarik dan inovatif dapat meningkatkan wawasan bagi mahasiswa dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Media visual

Termasuk di dalamnya adalah gambar, foto, diagram, grafik, dan ilustrasi. Media gambar dapat membantu menjelaskan konsep, memvisualisasikan informasi, atau memperjelas hubungan antara konsep-konsep yang kompleks. Media visual dapat berbentuk digital dimana media penyampaian informasi yang berbasis teknologi elektronik. Media ini ditampilkan melalui perangkat seperti smartphone, komputer, tablet, atau layar monitor. Contohnya seperti *e-book*/booklet digital, poster digital. Dalam bidang kesehatan, khususnya edukasi praoperasi, media ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pasien tanpa harus menggunakan unsur audio.

c. Media audiovisual

Merupakan jenis media yang dapat dilihat dan didengar, yang berguna dalam membantu menstimulasi indra mata (penglihatan) dan telinga pada waktu terjadinya proses penerimaan pesan. Termasuk di dalamnya adalah audio, video, dan multimedia. Media ini mencakup kombinasi audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas, seperti presentasi multimedia atau aplikasi edukatif. Beberapa manfaat dari media berbasis audiovisual yaitu:

- 1) Memudahkan seseorang mengingat
- 2) Penggunaan gambar juga dapat membuat seseorang lebih fokus, karena gambar dapat memusatkan perhatian.
- 3) Gambar dapat mempengaruhi gairah dan emosional pembaca, selain itu juga menambah kreatifitas

Hasil penelitian Nurillahi et al., (2025) dimana metode edukasi menggunakan *virtual room tour* efektif digunakan sebagai intervensi nonfarmakologis untuk meningkatkan kesiapan mental dan kenyamanan pasien sebelum menjalani prosedur operasi dengan anestesi regional berbasis audio-visual. Penelitian lain oleh Mayasari et al., (2025) menyimpulkan bahwa media edukasi menggunakan video animasi tentang anestesi spinal dapat berpengaruh menurunkan kecemasan pasien preoperasi. Video animasi mampu menyampaikan informasi secara visual dan audio, sehingga lebih mudah dipahami, terutama bagi pasien dengan tingkat pendidikan rendah atau yang mengalami kesulitan memahami penjelasan medis secara lisan atau tertulis.

d. Media *virtual reality* (VR) dan realitas augmentasi (AR)

Virtual reality merupakan teknologi computer yang memberikan pengalaman mendalam pada dunia simulasi 3D yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan virtualnya. Media ini telah dikembangkan sebagai pendekatan alternatif untuk mengurangi kecemasan

pasien preoperatif. Hasil penelitian Alaterre et al., (2020) menunjukkan bahwa program distraksi menggunakan *virtual reality* di ruang operasi dapat secara efektif meningkatkan kepuasan pasien melalui penurunan tingkat kecemasan dan memberikan manfaat terhadap stabilitas hemodinamik.

e. Media sosial

Media sosial berperan sebagai sarana efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran penyakit, serta mendukung program promosi kesehatan. Media sosial merupakan *platform* digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan mengakses informasi secara cepat dan luas. Dalam konteks kesehatan, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi praoperasi untuk menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga secara efektif, menarik, dan mudah diakses. Beberapa contoh platform yang sering digunakan antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Namun salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan media sosial yaitu informasi yang tidak valid atau penyebaran hoaks yang beredar secara masif.

f. Media interaktif

Termasuk didalamnya adalah aplikasi edukatif, simulasi, permainan pendidikan, dan perangkat lunak pembelajaran. Media interaktif memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dan memperoleh pengalaman langsung dalam menjelajahi konsep-konsep.

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Edukasi Kesehatan

a. Faktor individu

Faktor individu berkaitan dengan karakteristik setiap individu yang dapat memengaruhi kemampuan dalam menerima dan mengolah informasi kesehatan. Pemahaman awal dan latar belakang pendidikan menentukan sejauh mana seseorang mampu memahami materi edukasi. Pada konteks edukasi praoperasi kondisi psikologis seperti kecemasan, stress, dan kesiapan mental juga menentukan efektivitas edukasi. Pasien dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung sulit memahami informasi yang diberikan sebelum operasi. Sebaliknya, pasien yang memiliki pengetahuan awal yang baik akan lebih mudah menerima dan mengolah informasi.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya mencakup nilai, norma, kepercayaan, serta kebiasaan yang dianut oleh individu dan lingkungannya. Budaya dapat memengaruhi cara seseorang memandang kesehatan. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat penting, karena edukasi kesehatan akan lebih efektif jika didukung oleh lingkungan terdekatnya. Hambatan bahasa dan

perbedaan latar belakang budaya juga dapat memengaruhi keberhasilan komunikasi. Dalam edukasi praoperasi, dukungan keluarga menjadi faktor penting karena seorang pasien seringkali membutuhkan penguatan emosional sebelum tindakan operasi.

c. Faktor Lingkungan

Ketersediaan fasilitas kesehatan, akses informasi, serta dukungan sarana prasarana juga menentukan keberhasilan edukasi. Lingkungan edukasi praoperasi yang nyaman dan kondusif akan meningkatkan fokus pasien saat menerima informasi. Akses terhadap fasilitas edukasi seperti media audiovisual atau ruang konseling juga berpengaruh.

d. Faktor Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan edukasi karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta sikap empati dapat meningkatkan penerimaan pasien terhadap informasi. Kompetensi dan keterampilan dalam memilih metode edukasi juga menentukan efektivitas penyampaian pesan. Edukator yang mampu membangun hubungan terapeutik akan meningkatkan kepercayaan pasien.

e. Faktor Metode dan Media Edukasi

Metode dan media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik pasien. Metode edukasi praoperasi yang interaktif dan penggunaan media seperti video, animasi, atau aplikasi digital terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional (ceramah saja). Media audiovisual membantu pasien memahami prosedur yang kompleks dengan lebih mudah. Hasil penelitian Baghele et al., (2019) menunjukkan bahwa efek video informatif tentang teknik anestesi dengan menggunakan pemodelan teman sebaya sebagai metode edukasi praoperasi dapat membantu mengurangi kecemasan pada anak-anak berusia 7-12 tahun. Penelitian lain menurut Nugroho et al., (2020) penggunaan aplikasi audio visual spinal anestesi berbasis android dapat berpengaruh dalam menurunkan kecemasan pasien praoperasi. Bentuk edukasi menggunakan smartphone memiliki bentuk dan tampilan yang menarik dimana terdiri dari video dan musik Mozart yang memudahkan pasien dalam memahami informasi yang disampaikan.

f. Faktor Sistem dan Kebijakan

Faktor ini mencakup dukungan dari institusi dan kebijakan yang berlaku. Ketersediaan waktu untuk edukasi, standar operasional prosedur (SOP), serta dukungan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan sangat memengaruhi pelaksanaan edukasi. Dalam konteks edukasi praoperasi, keterbatasan waktu

dan beban kerja tenaga kesehatan sering menjadi hambatan dalam pemberian edukasi. Adanya standar operasional prosedur (SOP) dan dukungan institusi sangat penting agar edukasi dapat dilakukan secara konsisten dan optimal.

6. Lembar Observasi

Berikut contoh lembar observasi edukasi praoperasi.

LEMBAR OBSERVASI PENDIDIKAN KESEHATAN PRAOPERASI			Nama : NIM : Paraf :			
PENGERTIAN		Membantu pasien untuk memahami dan menyiapkan mental untuk pembedahan dan anestesi				
TUJUAN		1. Mengurangi kecemasan praoperasi 2. Memberikan pemahaman tentang tindakan pembedahan dan anestesi				
No .	Tahap	Aspek yang Dinilai	Pencapaian		Kompeten	
			YA	TDK	K	BK
1.	Pengkajian kebutuhan	a.Rencana dan jenis tindakan anestesi b. Adanya pasien yang cemas terhadap prosedur pembedahan dan anestesi				
2.	Persiapan alat	Media: leaflet atau lembar balik atau media lain sesuai dengan kondisi pasien				
3.	Persiapan pasien	Tempat pendidikan kesehatan dengan mempertimbangkan privasi pasien				
4.	Pelaksanaan	a.Pendidikan kesehatan dibuka dengan ramah dan sopan b. Maksud dan tujuan disampaikan c.Kontrak waktu d. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti e. Penggunaan media sesuai dengan rencana dan				

		tindakan pembedahan dan anestesi f. Materi dirangkum dengan jelas g. Evaluasi dilakukan sesuai tujuan pendidikan kesehatan h. Hasil evaluasi disampaikan kepada pasien dengan benar i. Acara ditutup dengan ucapan salam				
5.	Evaluasi dan tindak lanjut	a. Pasien tidak cemas terhadap tindakan pembedahan dan anestesi b. Upaya tindak lanjut tindakan dirumuskan c. Merencanakan tindakan sesuai dengan kondisi pasien				
6.	Dokumentasi	a. Tindakan, hasil dan respon pasien saat dan setelah tindakan dicatat dengan jelas dan ringkas sesuai prinsip dokumentasi b. Waktu, paraf dan nama jelas dicantumkan pada catatan pasien				

MINI CASE

Setelah mahasiswa membaca materi dengan seksama, mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus berikut.

1. Skenario 1

Seorang perempuan, umur 29 tahun dirawat di ruang kebidanan dan dijadwalkan menjalani operasi *sectio caesarea* elektif keesokan harinya. Saat pengkajian *pre visite* dari tim anestesi, pasien tampak gelisah, sering bertanya tentang proses operasi, dan mengatakan takut terhadap anestesi serta nyeri pasca operasi. Tim anestesi telah memberikan edukasi secara verbal, namun pasien masih terlihat bingung dan belum mampu menjelaskan kembali prosedur yang akan dijalani.

2. Skenario 2

Seorang perempuan, umur 22 tahun, diagnosis apendisitis direncanakan apendektomi dengan anestesi umum. Hasil pengkajian: TD 130/82mmHg, N 101x/menit, RR 22x/menit, akral teraba dingin, telapak tangan tampak basah, wajah pasien tegang.

Tugas Mahasiswa

1. Mengidentifikasi data subjektif dan objektif
2. Menganalisis tingkat kecemasan
3. Menentukan prioritas masalah
4. Merumuskan diagnosis/masalah
5. Menetapkan tujuan (SMART)
6. Menyusun rasional ilmiah

SOAL OSCE

Seorang perempuan, umur 47 tahun, diagnosis ca mammae sinistra akan dilakukan mastektomi dengan GA-ETT. Hasil pengkajian: pasien baru pertama kali ini akan menjalani operasi dan anestesi, TD 132/80mmHg, RR 22x/menit, N 102x/menit, akral dingin, tampak gelisah.

1.	No. Stasiun	1
2.	Judul	Kecemasan praoperasi
3.	Kasus	Manajemen kecemasan praoperasi pada pasien dengan diagnosis ca mammae sinistra akan dilakukan mastektomi dengan GA-ETT
4.	Tujuan	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian kecemasan dan implementasi

5.	Soal: Skenario dan tugas bagi peserta ujian	SKENARIO Seorang perempuan, umur 47 tahun, diagnosis ca mammae sinistra akan dilakukan mastektomi dengan GA-ETT. Hasil pengkajian: pasien baru pertama kali ini akan menjalani operasi dan anestesi, TD 132/80mmHg, RR 22x/menit, N 102x/menit, akral dingin, tampak gelisah. TUGAS 1. Lakukan pengkajian kecemasan dengan instrumen APAIS 2. Ajarkan manajemen kecemasan dengan cara relaksasi napas dalam
6.	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 6. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 7. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut 8. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian 9. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun (interupsi, bertanya, menghentikan, dst) kepada peserta selain yang ditentukan. 10. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE INSTRUKSI KHUSUS 1. Ketika peserta ujian menanyakan diluar dari skenario dialog, penguji akan mengatakan “Tidak ada data”. 2. Beri nilai kertas yang dituliskan hasil pengkajian dari peserta ujian. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Tidak ada

7.	Kebutuhan dan dialog PS	Ada/Tidak ada Deskripsi PS: Seorang perempuan dewasa yang dikondisikan: - Berusia 47 tahun yang terbaring di tempat tidur. Dialog <table><tr><th>Peserta Ujian (PU)</th><th>Pasien Simulasi (PS)</th></tr><tr><td>Mengucapkan salam</td><td>Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja).</td></tr><tr><td>Menanyakan nama dan tanggal lahir</td><td>Menyebutkan nama sendiri, tanggal lahir 1 Januari 1979.</td></tr><tr><td colspan="2">PENGKAJIAN</td></tr><tr><td>Menanyakan keluhan</td><td>Menjawab: - Takut akan dioperasi - Ini pertama kali ini akan menjalani operasi - Takut dibius </td></tr><tr><td>Menanyakan penilaian kecemasan dengan APAIS</td><td> - Pertanyaan apakah merasa takut dibius dijawab setuju - Pertanyaan apakah terus menerus memikirkan tentang pembiusan dijawab setuju - Pertanyaan apakah ingin tahu sebanyak mungkin tentang pembiusan dijawab sangat setuju - Pertanyaan apakah takut dioperasi dijawab setuju - Pertanyaan apakah terus-menerus memikirkan operasi dijawab setuju - Pertanyaan apakah ingin tahu sebanyak mungkin </td></tr></table>	Peserta Ujian (PU)	Pasien Simulasi (PS)	Mengucapkan salam	Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja).	Menanyakan nama dan tanggal lahir	Menyebutkan nama sendiri, tanggal lahir 1 Januari 1979 .	PENGKAJIAN		Menanyakan keluhan	Menjawab: - Takut akan dioperasi - Ini pertama kali ini akan menjalani operasi - Takut dibius	Menanyakan penilaian kecemasan dengan APAIS	- Pertanyaan apakah merasa takut dibius dijawab setuju - Pertanyaan apakah terus menerus memikirkan tentang pembiusan dijawab setuju - Pertanyaan apakah ingin tahu sebanyak mungkin tentang pembiusan dijawab sangat setuju - Pertanyaan apakah takut dioperasi dijawab setuju - Pertanyaan apakah terus-menerus memikirkan operasi dijawab setuju - Pertanyaan apakah ingin tahu sebanyak mungkin
Peserta Ujian (PU)	Pasien Simulasi (PS)													
Mengucapkan salam	Membalas salam (jika PU tidak memberikan salam, diam saja).													
Menanyakan nama dan tanggal lahir	Menyebutkan nama sendiri, tanggal lahir 1 Januari 1979 .													
PENGKAJIAN														
Menanyakan keluhan	Menjawab: - Takut akan dioperasi - Ini pertama kali ini akan menjalani operasi - Takut dibius													
Menanyakan penilaian kecemasan dengan APAIS	- Pertanyaan apakah merasa takut dibius dijawab setuju - Pertanyaan apakah terus menerus memikirkan tentang pembiusan dijawab setuju - Pertanyaan apakah ingin tahu sebanyak mungkin tentang pembiusan dijawab sangat setuju - Pertanyaan apakah takut dioperasi dijawab setuju - Pertanyaan apakah terus-menerus memikirkan operasi dijawab setuju - Pertanyaan apakah ingin tahu sebanyak mungkin													

			tentang operasi dijawab sangat setuju
		IMPLEMENTASI	
		Menjelaskan tujuan. Meminta memposisikan diri dengan nyaman. Memperagakan sambil menjelaskan teknik relaksasi dan meminta PS untuk menirukannya: - Meminta untuk menarik atau menghirup napas dalam dari hidung melalui hitungan 1,2,3,4 kemudian ditahan sekitar 3-5 detik. - Meminta untuk menghembuskan napas, hitung sampai tiga secara perlahan melalui mulut. - Meminta untuk berkonsentrasi supaya rasa cemas yang dirasakan bisa berkurang, bisa dengan memejamkan mata. - Meminta untuk mengulang prosedur hingga kecemasan berkurang dan selingi istirahat singkat	Ikuti instruksi yang diberikan: Mendengarkan instruksi sambil meniru apa yang dilakukan oleh peserta ujian

		Catatan: Ketika peserta ujian menanyakan diluar dari skenario dialog, PS diam saja dan penguji akan mengatakan “ <u>Tidak ada data</u> ”.															
8.	Kebutuhan manekin, alat dan BHP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Alat dan Bahan</th><th>Jumlah*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Stopwatch</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tensimeter</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pulse oximetry</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kertas</td><td>Sejumlah peserta ujian.</td></tr> </tbody> </table>	No.	Alat dan Bahan	Jumlah*	1.	Stopwatch	1 buah	2.	Tensimeter	1 buah	3.	Pulse oximetry	1 buah	4.	Kertas	Sejumlah peserta ujian.
No.	Alat dan Bahan	Jumlah*															
1.	Stopwatch	1 buah															
2.	Tensimeter	1 buah															
3.	Pulse oximetry	1 buah															
4.	Kertas	Sejumlah peserta ujian.															
10.	Kebutuhan laboran	Tidak ada.															
11.	Penulis	Tim															
12.	Referensi	Pramono, Ardi.(2017). Buku kuliah anestesi. Jakarta: EGC															

A. DOPS

FORMAT *DIRECT OBSERVATIONAL PROCEDURAL SKILLS* (DOPS)

Nama :

Tanggal :

Tempat :

Materi : Pendidikan kesehatan praoperasi

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik). Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 (dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5 (melebihi target yang ditetapkan)

1. Penyampaian *informed consent*

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

2. Persiapan sebelum pemeriksaan

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait dan teknik prosedur

O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

5. Kemampuan teknis
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5
6. Teknik aseptik
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5
7. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5
8. Manajemen kasus
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5
9. Ketrampilan komunikasi
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5
10. Profesionalisme penanganan pasien
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5
11. Kemampuan Umum untuk tindakan secara keseluruhan
O tidak diamati/ tidak diterapkan O1 O2 O3 O4 O5

C. RANGKUMAN

Kecemasan merupakan respon umum yang dialami pasien akibat ketidakpastian terhadap prosedur pembedahan, anestesi, dan kemungkinan komplikasi. Jika tidak ditangani, kecemasan dapat memengaruhi kondisi fisiologis seperti peningkatan tekanan darah, nadi, dan frekuensi pernapasan, serta berdampak pada keberhasilan tindakan operasi. Manajemen kecemasan dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Edukasi praoperasi merupakan bagian integral dalam manajemen kecemasan, yang meliputi pemberian informasi mengenai prosedur operasi, anestesi, persiapan fisik, serta perawatan pascaoperasi. Dengan demikian, kombinasi antara manajemen kecemasan dan edukasi praoperasi menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan pasien, memperlancar proses pembedahan, serta mendukung hasil pemulihan.

Glosarium

Anestesi umum: tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyeri, membuat tidak sadar, dan menyebabkan amnesia yang bersifat reversibel dan dapat diprediksi.

Anestesi spinal: teknik anestesi regional dengan cara menyuntikkan obat anestesi ke dalam ruang subaraknoid (cairan serebrospinal) di tulang belakang.

Apendiktomi: tindakan pembedahan untuk mengangkat apendiks (usus buntu), biasanya dilakukan pada pasien dengan appendisitis.

Appendisitis: peradangan pada usus buntu (apendiks) yang biasanya ditandai dengan nyeri perut kanan bawah, mual, muntah, dan demam. Kondisi ini sering memerlukan tindakan operasi.

Ca Mamae: istilah medis untuk kanker payudara, yaitu pertumbuhan sel ganas pada jaringan payudara.

Gingivektomy: salah satu prosedur operasi gusi yang dilakukan untuk mengangkat jaringan gusi atau gingiva. Gingivektomi bermanfaat untuk mengobati penyakit gusi seperti gingivitis serta untuk menghilangkan jaringan gusi yang berlebihan.

Guided Imagery: teknik relaksasi yang menggunakan imajinasi atau visualisasi mental untuk menciptakan suasana yang menenangkan, sehingga membantu mengurangi stres, kecemasan, dan ketegangan.

Hernia: benjolan yang timbul akibat keluarnya organ dalam tubuh lewat jaringan di sekitarnya yang sudah melemah.

Laparotomi: prosedur bedah untuk membuka rongga perut yang melibatkan sayatan pada dinding perut untuk mengakses organ-organ di dalamnya yang bertujuan untuk mendiagnosis, memperbaiki, atau mengangkat organ-organ yang sakit atau cedera, mengangkat tumor dan memberikan perawatan pada gangguan tertentu pada organ di rongga perut.

Mastektomi: prosedur pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh payudara, biasanya dilakukan pada pasien dengan kanker payudara.

N (Nadi): gelombang denyutan yang terasa pada pembuluh darah arteri akibat kontraksi jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh.

ORIF (*Open Reduction And Internal Fixation*): atau fiksasi internal adalah prosedur penyambungan kembali tulang dengan cara mengarahkan tulang bersatu menggunakan pelat logam, pin, atau sekrup.

Praoperasi: fase atau tahap persiapan yang dilakukan sebelum tindakan pembedahan.

Pre visit: kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, perawat, atau penata anestesi) kepada pasien sebelum tindakan operasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi akhir, memberikan edukasi, serta memastikan kesiapan pasien secara fisik dan psikologis sebelum masuk ke ruang operasi.

RR (*Respiratory rate*): frekuensi pernapasan adalah jumlah napas (inspirasi dan ekspirasi) yang terjadi dalam satu menit.

Relaksasi benson: merupakan teknik untuk menurunkan stres dan kecemasan dengan cara memicu *relaxation response* (respon relaksasi) dalam tubuh. Relaksasi ini menggabungkan pernapasan dalam dengan pengulangan kata atau kalimat yang menenangkan.

Sectio caesarea: merupakan suatu prosedur pembedahan dengan menyayat bagian dinding uterus melalui dinding depan perut untuk mengeluarkan janin dari rahim ibu.

Sinistra: istilah medis dari bahasa Latin yang berarti kiri. Digunakan untuk menunjukkan lokasi, misalnya payudara kiri atau bagian tubuh sebelah kiri.

TD (tekanan darah): tekanan yang dihasilkan oleh aliran darah terhadap dinding pembuluh arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh.

Quarter life crisis: kondisi psikologis yang dialami seseorang, umumnya pada usia sekitar 20–30 tahun, yang ditandai dengan perasaan cemas, bingung, tidak pasti, dan tekanan terkait arah hidup, karier, hubungan, maupun tujuan masa depan.

Referensi

- Abbasiah et al. (2023). *Bunga Rampai Promosi Kesehatan*. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama
- Alaterre, C., Duceau, B., Tsai, E. S., Zriouel, S., Bonnet, F., Lescot, T., & Verdonk, F. (2020). Virtual reality for peripheral regional anesthesia (VR-PERLA study). *Journal of Clinical Medicine*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/jcm9010215>
- Alsufyani, F., Katooa, N., Al-Zahrani, A., Felemban, O., Badr, H., & Thabet, H. (2024). The Impact of Educational Sessions on Anxiety Levels among Women Undergoing Caesarean Section: A Quasi-Experimental Study. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 14(2), 324–338. <https://doi.org/10.3390/ejihpe14020022>
- American Psychological Association. (2018). Anxiety. American Psychological Association. <https://www.apa.org/topics/anxiety>
- Anamagh, M. A., Kouhpayeh, M. S., Khezri, S., Goli, R., Faraji, N., Anzali, B. C., Maroofi, H., Eskandari, N., & Ghahremanzad, F. (2024). The effect of Guided imagery on perioperative anxiety in hospitalized adult patients: A systematic review of randomized controlled trials. In *Surgery in Practice and Science* (Vol. 18). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sipas.2024.100255>
- Asda, P & Sekarwati, N. (2023). *Pendidikan & Promosi Kesehatan*. Nganjuk: Dewa Publishing
- Baghele, A., Dave, N., Dias, R., & Shah, H. (2019). Effect of preoperative education on anxiety in children undergoing day-care surgery. *Indian Journal of Anaesthesia*, 63(7), 565–570. https://doi.org/10.4103/ija.IJA_37_19
- Dwairaj, D., Obeidat, H., & Khalaf, I. (2018). The Effectiveness of Video Distraction on Children Preoperative Anxiety: An Integrative Literature Review. *Open Journal of Nursing*, 08(03), 171–187. <https://doi.org/10.4236/ojn.2018.83015>
- Nuraini, R., Ari., W.O. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi. In *Jurnal Kesehatan Akper Kesdam II Sriwijaya Palembang*, 12(1). <https://ojs.hestiwirasriwijaya.ac.id/index.php/JSS/article/view/63>
- Kadek Nirmala Sari, N., Wayan Agus Maharyawan, I., Ileana Lewar, E., & Luh Putu Lusiana Devi, N. (2024). Effectiveness of educational videos on reducing anxiety in pre-anesthesian patients. *Journal of Language and Health*, 5(1) <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JLH>
- Mayasari, D. N. S., Handayani, N., & Setyowati, A. (2025). Pengaruh Edukasi Video Animasi Anestesi Spinal Terhadap Kecemasan Pasien Preoperasi Di Rs

- Pku Muhammadiyah Bantul. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(3).
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/47301>
- Murti, B. (2018). *Teori Promosi dan Perilaku Kesehatan*. Surakarta: UNS
- Ningrat, B. B., Yudono, D. T., & Susanto, A. (2026). Pengaruh Pemberian Audiovisual Animasi Motion Graphic Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea Dengan Spinal Anestesi Di RSUD Pandega Pangandaran. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 8. Retrieved <https://bnj.akys.ac.id/BNJ>
- Nisa, A.S.C & Rosyid, F.N. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Tentang Covid-19 Dengan Tingkat Kecemasan Masyarakat di Era New Normal. *Malahayati Nursing Journal*, 5(11).
<https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/view/9603>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, N.M.A., Sutejo., & Prayogi, A.S. (2020). The Effect Of Android Audio Visual Health Education On Anxiety Pre Spinal Anesthesia Patients in PKU Muhammadiyah Bantul Hospital Pengaruh Pendidikan Kesehatan Audio Visual Android Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Spinal Anestesi di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. *Journal of Health Technology*, 16(1), 8–15.
<https://ejournal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/JTK/article/view/558>
- Nurillahi, I.S., Sebayang, S.M., & Ningrum, E.W. (2025). Pengaruh Edukasi Virtual Room Tour Terhadap Kecemasan Pasien Pra Operasi Anestesi Regional Di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. *Jurnal Kesehatan Jompa*, 4 (1).
<https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jkj/article/view/1454>
- Pratiwi, A., & Samiasih, A. (2022). Penerapan Terapi Relaksasi Benson Pasien Pre Operasi Bedah Mulut (Gingivectomy) yang Mengalami Kecemasan. *Ners Muda*, 3(3). <https://doi.org/10.26714/nm.v3i3.10248>
- Purnamasari, V., Handayani, N., Nur Azizah, A. (2025). Pengaruh Edukasi Self Healing Berbasis Digital Terhadap Quarter Life Crisis Pada Mahasiswa Prodi Keperawatan Anestesiologi. *J-Sikep*, 6 (1) <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/J-SiKep>
- Ramadhani, N. P., Handayani, N., & Murdiyanto, J. (2025). Pengaruh Edukasi Agitasi Pasca Anestesi Umum Terhadap Pengetahuan Keluarga Pasien Pre Operasi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 14(1).
<https://ojs.widyagamahusada.ac.id>
- Stuart, G.W., & Sudeen. (2016). *Principle and Practice of Psychiatric Nursing* (I ed.). Elsevier Inc.

Tumurang, M.N. (2018). *Promosi Kesehatan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka

Profil Penulis



Ns. Rully Annisa, S.Kep., M.Kep.

dilahirkan di Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Juli 1985. Penulis menempuh pendidikan S1 dan Profesi Ners di Universitas Muhammadiyah Purwokerto bidang Ilmu Keperawatan dan S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bidang Keperawatan.

Penulis adalah Dosen Swasta di program studi Keperawatan Anestesiologi D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan telah menghasilkan lebih dari 7 buku nasional. Penulis mendapatkan hibah penelitian Dikti tahun 2020. Pada tahun 2022, penulis pernah mengikuti program pelatihan/ magang tentang *Traditional Medicine* dari Dikti Vokasi di University of Rhode Island USA selama 4 minggu.

Penulis telah menjadi dosen selama 9 tahun dan telah membantu mengajar ribuan mahasiswa S1 dan Profesi Ners. Penulis juga menjadi moderator oral presentation pada *International Nursing & Health Science* di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap ilmu keperawatan anestesiologi dimulai sejak menjadi dosen vokasi keperawatan anestesiologi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan berlanjut sampai sekarang.

Email Penulis: rullyannisa20@gmail.com

Motto: "Ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah yang tak pernah terputus."

Profil Penulis



Anita Setyowati, M.Tr.Kep.

Anita Setyowati, M.Tr.Kep, adalah seorang akademisi dan praktisi keperawatan anestesi yang berdedikasi mengembangkan ilmu keperawatan perioperatif di Indonesia. Sejak tahun 2019, ia mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, membina generasi perawat anestesi melalui pengajaran, bimbingan skripsi, dan pendampingan praktik klinik mahasiswa.

Perjalanan akademiknya dimulai dari pendidikan D4 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kemudian diperdalam melalui program Magister Terapan Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Bekal keilmuan ini menjadikannya sosok yang concern terhadap isu manajemen nyeri, stabilitas hemodinamik, dan intervensi nonfarmakologi berbasis bukti ilmiah.

Ketertarikannya pada dunia riset tercermin dari sejumlah karya yang telah dipublikasikan, mulai dari eksplorasi terapi nature sound dan foot massage untuk mengatasi nyeri pasca operasi, kajian kecemasan mahasiswa keperawatan anesthesiologi, hingga penelitian tentang efektivitas aromaterapi lemon dalam menekan mual muntah pasca anestesi spinal. Konsistensi ini menegaskan komitmennya menghadirkan solusi keperawatan yang inovatif, aplikatif, dan berpihak pada kenyamanan pasien.

Motto : Belajar tak pernah selesai, sebab hidup adalah proses yang terus berkembang

Profil Penulis



Nia Handayani, S.Tr.Kep., M.K.M.

merupakan dosen Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma IV Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta dan melanjutkan studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret.

Sebagai akademisi, Nia Handayani aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang yang menjadi fokus pengembangan keilmuannya meliputi promosi kesehatan, keperawatan perioperatif, keselamatan pasien, serta inovasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Berbagai aktivitas akademik tersebut menjadi wujud komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Melalui buku ini, penulis berharap setiap materi yang disajikan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, akademisi, maupun pembaca umum. Penulis juga berharap buku ini mampu menginspirasi lahirnya gagasan-gagasan baru serta mendorong penerapan ilmu secara nyata demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Penulis meyakini bahwa ilmu pengetahuan akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dibagikan dan diterapkan dalam kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, beliau mengusung

motto: "Menebar ilmu, menginspirasi perubahan, dan menghadirkan manfaat bagi kehidupan."

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Perioperatif ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan yang ingin memahami konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien yang menjalani tindakan pembedahan. Keperawatan perioperatif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena mencakup rangkaian asuhan keperawatan secara komprehensif, mulai dari fase praoperasi, intraoperasi, hingga pascaoperasi, dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan pasien, mencegah komplikasi, serta mendukung proses pemulihan secara optimal.

Buku ini membahas dasar-dasar keperawatan perioperatif dengan penekanan pada keselamatan pasien sebagai prinsip utama dalam setiap tahap pelayanan pembedahan. Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan perioperatif, ruang lingkup praktik, peran dan tanggung jawab perawat, serta pentingnya penerapan standar keselamatan pasien dalam pelayanan bedah. Materi ini memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan tindakan operasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur medis, tetapi juga oleh kualitas asuhan keperawatan yang sistematis, aman, dan berpusat pada pasien.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian praoperasi dan persiapan pasien sebagai bagian penting dalam mencegah risiko selama proses pembedahan. Pembaca akan diarahkan untuk memahami tahapan pengumpulan data, identifikasi faktor risiko, pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis pasien, persiapan administrasi, persiapan fisik, serta koordinasi dengan tim kesehatan. Materi ini menekankan pentingnya ketelitian perawat dalam memastikan kesiapan pasien sebelum tindakan operasi dilakukan.

Buku ini juga membahas manajemen kecemasan dan edukasi praoperasi. Kecemasan merupakan respons yang umum dialami pasien sebelum menjalani pembedahan dan dapat memengaruhi kondisi fisiologis maupun psikologis pasien. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, komunikasi terapeutik, serta edukasi yang jelas dan mudah dipahami. Edukasi praoperasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pasien, menurunkan kecemasan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, dan mendukung keberhasilan perawatan perioperatif.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang sistematis, aplikatif, dan relevan dalam membentuk kemampuan mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan perioperatif yang profesional, aman, humanis, dan berbasis pada kebutuhan pasien. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan perioperatif.

Buku Ajar Keperawatan Perioperatif ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan yang ingin memahami konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien yang menjalani tindakan pembedahan. Keperawatan perioperatif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena mencakup rangkaian asuhan keperawatan secara komprehensif, mulai dari fase praoperasi, intraoperasi, hingga pascaoperasi, dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan pasien, mencegah komplikasi, serta mendukung proses pemulihan secara optimal.

Buku ini membahas dasar-dasar keperawatan perioperatif dengan penekanan pada keselamatan pasien sebagai prinsip utama dalam setiap tahap pelayanan pembedahan. Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan perioperatif, ruang lingkup praktik, peran dan tanggung jawab perawat, serta pentingnya penerapan standar keselamatan pasien dalam pelayanan bedah. Materi ini memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan tindakan operasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur medis, tetapi juga oleh kualitas asuhan keperawatan yang sistematis, aman, dan berpusat pada pasien.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian praoperasi dan persiapan pasien sebagai bagian penting dalam mencegah risiko selama proses pembedahan. Pembaca akan diarahkan untuk memahami tahapan pengumpulan data, identifikasi faktor risiko, pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis pasien, persiapan administrasi, persiapan fisik, serta koordinasi dengan tim kesehatan. Materi ini menekankan pentingnya ketelitian perawat dalam memastikan kesiapan pasien sebelum tindakan operasi dilakukan.

Buku ini juga membahas manajemen kecemasan dan edukasi praoperasi. Kecemasan merupakan respons yang umum dialami pasien sebelum menjalani pembedahan dan dapat memengaruhi kondisi fisiologis maupun psikologis pasien. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, komunikasi terapeutik, serta edukasi yang jelas dan mudah dipahami. Edukasi praoperasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pasien, menurunkan kecemasan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, dan mendukung keberhasilan perawatan perioperatif.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang sistematis, aplikatif, dan relevan dalam membentuk kemampuan mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan perioperatif yang profesional, aman, humanis, dan berbasis pada kebutuhan pasien. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan perioperatif.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-63-3 (PDF)



9

786347

756633

